Institutionen för hälsovetenskap, innovation och design

BEMÖTANDE FRÅN VÅRDPERSONAL VID VÅLD I NÄRA RELATION

En allmän litteraturöversikt ur kvinnors perspektiv

SANDRA LEHMAN
MARIA LINDGREN

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning på omvårdnad
Nivå: Grundnivå
Högskolepoäng: 15 högskolepoäng
Program: Sjuksköterskeprogrammet
Kursnamn: Examensarbete med inriktning mot omvårdnad
Kurskod: VAE209

Handledare: Jessica Nordh
Examinator: Viivi Tikkanen

Seminariedatum: 2026-06-04
Betygsdatum: 2026-06-10

SAMMANFATTNING

Bakgrund: Våld i nära relation är ett globalt folkhälsoproblem som påverkar kvinnors fysiska och psykiska hälsa samt deras kontakt med vården. Vårdpersonal har en viktig roll i att identifiera och bemöta dessa kvinnor inom hälso- och sjukvården. **Syfte:** Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av bemötandet från vårdpersonal inom hälso- och sjukvården vid våld i nära relation. **Metod:** En allmän litteraturöversikt genomfördes där tolv vetenskapliga artiklar analyserades. Tio av artiklarna hade kvalitativ ansats och två hade kvantitativ. Materialet analyserades genom en integrerad analys. **Resultat:** Ett empatiskt, lyhört och respektfullt bemötande var avgörande för att skapa trygghet och tillit, vilket ökade kvinnornas benägenhet att berätta om sin utsatthet. Brister i bemötandet, såsom tidsbrist, bristande kunskap och engagemang bidrog till erfarenheter av att inte bli trodd eller bekräftad. Även organisatoriska faktorer och vårdmiljön påverkade deras erfarenheter av bemötandet. **Slutsats:** Bemötandet från vårdpersonalen hade betydelse för kvinnors erfarenheter inom vården vid våld i nära relation. Ett personcentrerat och empatiskt förhållningssätt samt förbättrade organisatoriska förutsättningar var viktiga för att stärka vårdens kvalitet och minska lidande. Ökad kunskap, tydliga riktlinjer och organisatoriskt stöd behövs för att förbättra vårdpersonalens förutsättningar att ge ett tryggt och jämlikt bemötande framöver.

Nyckelord: allmän litteraturöversikt, bemötande, erfarenheter, kvinnor, vårdpersonal, våld i nära relation.

ABSTRACT

Background: Intimate partner violence is a global public health issue affecting women's physical and mental health and their contact with healthcare services. Healthcare professionals have an important role in identifying and supporting exposed women within healthcare service. **Aim:** The aim was to describe women's experiences of encounters from healthcare professionals within healthcare services in situations of intimate partner violence. **Method:** A general literature review was conducted based on twelve scientific articles, of which ten had a qualitative approach and two had a quantitative approach. The material was analyzed using an integrated analysis. **Results:** An empathetic, attentive, and respectful encounter was essential in creating safety and trust, increasing women's willingness to disclose abuse. Deficiencies such as lack of time, knowledge, and engagement contributed to women feeling ignored or not believed. Organizational factors and the care environment also influenced women's experiences. **Conclusion:** The encounter from healthcare professionals was significant for women's experiences within healthcare in situations of intimate partner violence. A person-centered and empathetic approach, together with improved organizational conditions is important to strengthen quality of care and reduce suffering. Increased knowledge, clear guidelines, and organizational support are needed to improve healthcare professionals ability to provide safe and equitable care.

Keywords: encounter, experiences, general literature review, healthcare professionals, intimate partner violence, women.

INNEHÅLL

1 INLEDNING 1

2 BAKGRUND 1

2.1 Centrala begrepp 1

2.1.1 Våld i nära relation 2

2.1.2 Hälso- och sjukvården 2

2.1.3 Vårdmöte 2

2.1.4 Bemötande 3

2.1.5 Vårdpersonal 3

2.2 Tidigare forskning 3

2.2.1 Sjuksköterskors arbete vid våld i nära relation 3

2.2.2 Sjuksköterskors kompetens vid våld i nära relation 4

2.2.3 Organisatoriska förutsättningar i vården 4

2.3 Vårdvetenskapligt perspektiv 5

2.3.1 Katie Erikssons caritativa vårdteori 5

2.4 Lagar och riktlinjer 6

2.4.1 Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 6

2.4.2 Patientlagen 6

2.4.3 Socialstyrelsens handbok vid våld i nära relation 6

2.5 Problemformulering 7

3 SYFTE 7

4 METOD 7

4.1 Datainsamling och urval 8

4.2 Genomförande och analys 10

4.3 Etiska överväganden 10

5 RESULTAT 11

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte 11

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod 14

5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 16

5.3.1 Att våga berätta 16

5.3.2 Synliggörande av våld i nära relation 17

5.3.3 Betydelsen av organisatoriska förutsättningar 17

5.3.4 Bemötandets konsekvenser för framtida vårdkontakt 18

6 DISKUSSION 19

6.1 Resultatdiskussion 19

6.1.1 Diskussion av artiklarnas syfte och metod 19

6.1.2 Diskussion av artiklarnas resultat 20

6.2 Metoddiskussion 22

6.3 Etikdiskussion 25

7 SLUTSATS 26

7.1 Kliniska implikationer 26

7.2 Förslag på framtida forskning 27

REFERENSLISTA 28

BILAGA A; SÖKMATRIS

BILAGA B; KVALITETSGRANSKNING

BILAGA C; ARTIKELMATRIS

1 INLEDNING

En arbetsdag inom hälso- och sjukvården kan innebära möten med patienter i komplexa och utmanande vårdsituationer. En patientgrupp som sjuksköterskor kan möta inom hälso- och sjukvården är kvinnor som utsatts för våld i nära relation. Dessa kvinnor kan söka vård av olika orsaker och därmed komma i kontakt med sjuksköterskor inom flera delar av vården. Inom hälso- och sjukvården kan sjuksköterskor möta kvinnor med både fysiska och psykiska konsekvenser av våld i nära relation. I dessa vårdsituationer kan bemötande, kommunikation och stöd vara en del av vårdmötet. Vården kan även innefatta dokumentation av skador samt vidare hänvisning till andra stödinsatser.

Författarnas förförståelse utgörs av att vara sjuksköterskestudenter och därigenom ha erhållit kunskap om våld i nära relation, personcentrerad vård och sjuksköterskors ansvar inom hälso- och sjukvården. Författarna har även erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning inom olika delar av hälso- och sjukvården där patienter i utsatta livssituationer förekommit.

Detta intresseområde har valts då det framstår som angeläget och utmanande inom hälso- och sjukvården. Intresset väcktes genom diskussioner kring sjuksköterskors roll samt våld i nära relation som samhällsfenomen. Intresseområdet är inspirerat av området ”Akutsjukvård” i intresseområdeslistan från Mälardalens universitet. I arbetet har ämnet dock breddats till hälso- och sjukvården generellt för att möjliggöra en mer omfattande analys.

2 BAKGRUND

Bakgrunden innehåller en beskrivning av centrala begrepp som tas upp i arbetet för att förtydliga dess innebörd. Avsnittet inkluderar även tidigare forskning för att belysa det nuvarande kunskapsläget inom området samt en problemformulering som belyser behovet av ökad kunskap. Som vårdvetenskaplig teori beskrivs Katie Erikssons caritativa vårdteori. Vidare beskrivs sjuksköterskors professionella ansvar gällande etiska och yrkesmässiga riktlinjer för att belysa vilka aspekter som är viktiga i bemötandet med patienten.

2.1 Centrala begrepp

För att underlätta förståelsen av arbetet beskrivs nedan centrala begrepp som är relevanta för innehållet.

2.1.1 Våld i nära relation

Våld i nära relation avser handlingar där en individ utsätts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av en person som den har, eller har haft, en nära relation till. Begreppet omfattar flera olika former av våld, såsom fysiskt våld, hot, kontroll, kränkningar och sexuella övergrepp (Socialstyrelsen, 2023; Sundborg, 2024). Enligt Sundborg (2024) kan vissa former av våld i nära relation vara svårare att uppmärksamma eftersom de inte alltid lämnar synliga skador.

Dessa handlingar kan förekomma inom exempelvis parrelationer eller familjer och kännetecknas ofta av en maktobalans mellan förövare och den utsatta. Våldet kan vara både enstaka händelser och upprepade handlingar över tid och det kan få allvarliga konsekvenser för den utsattas fysiska och psykiska hälsa samt sociala livssituation (Socialstyrelsen, 2023). I föreliggande arbete riktas fokus mot kvinnor som utsatts för våld i nära relation.

2.1.2 Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården omfattar bedömning, utredning, diagnostik, behandling, rehabilitering samt uppföljning av patienters vårdbehov. Begreppet innefattar även omvårdnad, vilket innebär att stödja patientens återhämtning, funktion och hälsa över tid. Hälso- och sjukvården omfattar olika vårdnivåer och verksamheter, såsom primärvård, specialistvård och sjukhusvård samt andra vårdinsatser inom exempelvis kommunal vård och psykiatri (Socialstyrelsen, 2024). Med hälso- och sjukvården avses i detta arbete de vårdkontexter där kvinnor som utsatts för våld i nära relation möter vårdpersonal.

2.1.3 Vårdmöte

Vårdmötet beskrivs som en situation där vårdaren strävar efter att etablera en förtroendefull relation till patienten. Utgångspunkten i mötet är patientens egen berättelse, vilken ligger till grund för planeringen och genomförande av vården. Genom detta kan ett partnerskap mellan patient och vårdpersonal utvecklas, vilket i sin tur kan skapa förutsättningar för hälsa och läkande (Ternestedt & Norberg, 2019).

Detta synsätt stöds även av Ekeberg (2022b) som betonar att vårdmötet kräver att sjuksköterskor tydligt visar att patienten är i fokus och att dennes behov uppmärksammas i mötet. Författaren lyfter även vikten av att möta patientens livsvärld, vilket förutsätter att sjuksköterskor är lyhörda och visar nyfikenhet i sitt agerande.

Enligt Bentling (2010) kan vårdmötet även förstås som en pedagogisk situation där sjuksköterskor använder sin pedagogiska kompetens genom att informera och undervisa patienten. Författarna betonar även vikten av att patientens autonomi respekteras i mötet, vilket innebär att patienten ska ges möjlighet att vara delaktig i beslut som rör den egna vården. I detta arbete avser vårdmötet den vårdsituation där mötet mellan sjuksköterskor och kvinnor som utsatts för våld i nära relation äger rum.

2.1.4 Bemötande

Begreppet bemötande kan förstås som hur vårdpersonal förhåller sig till patienten i mötet, där respekt, lyhördhet och helhetssyn på människan utgör viktiga delar. Ett gott bemötande förutsätter att patienten ses som en hel person, där såväl fysiska, psykiska som existentiella behov beaktas. Bemötandet blir därmed en grundläggande förutsättning för att ett vårdande möte ska kunna uppstå (Willman, 2019).

Vidare beskrivs bemötande som själva handlingen att möta en annan människa. För vårdpersonal innebär detta en förmåga att möta människor i lidande, vilket är en viktig del i omvårdnadsarbetet. Detta innefattar inte enbart att hantera patientens lidande, utan också att förhålla sig till sitt eget lidande, då mötet kan väcka starka känslor (Ekebergh 2022a). I arbetet avser begreppet hur vårdpersonal och kvinnor som utsatts för våld i nära relation interagerar och förhåller sig till varandra i vårdmötet.

2.1.5 Vårdpersonal

Vårdpersonal är ett samlingsbegrepp som innefattar personer som har legitimation eller innehar ett särskilt förordnande inom vården. Det omfattar även personer som arbetar tillsammans med legitimerad personal och bidrar i omvårdnaden av patienter. Begreppet inkluderar vidare personal som är verksam inom sjukhus eller andra vårdinrättningar och som på olika sätt medverkar i patientvården (Socialstyrelsen, 2025). I detta arbete avses med vårdpersonal den personal som möter kvinnor som utsatts för våld i nära relation inom hälso- och sjukvården, där sjuksköterskor ingår som en del av yrkesgruppen.

2.2 Tidigare forskning

Avsnittet beskriver tidigare forskning om sjuksköterskors arbete vid våld i nära relation, deras kompetens samt de organisatoriska förutsättningarna inom sjukhusvård som påverkar arbetet med kvinnor som utsatts för våld i nära relation.

2.2.1 Sjuksköterskors arbete vid våld i nära relation

Sjuksköterskor har en roll i att identifiera, bemöta och stödja kvinnor som utsätts för våld i nära relation inom hälso- och sjukvården (Alshammari et al., 2018; Aydin & Karaçar, 2025; Briones-Vozmediano et al., 2022; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Duchesne et al., 2023; Gandhi et al., 2018; Li et al., 2024; Rahmqvist et al., 2019; Ruiz-Fernández et al., 2022).

I sitt kliniska arbete möter sjuksköterskor kvinnor som söker vård för konsekvenser av våld i nära relation, vilket innebär att uppmärksammande av tecken ingår i arbetet. Arbetet omfattar även att skapa förutsättningar för att kvinnan ska kunna berätta om sin situation (Alshammari et al., 2018; Aydin & Karaçar, 2025; Briones-Vozmediano et al., 2022; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Gandhi et al., 2018; Rahmqvist et al., 2019; Renner et al., 2019; Ruiz-Fernández et al., 2022).

Samtidigt framkommer erfarenheter av att arbetsuppgifterna kan vara emotionellt betungande när de möter kvinnor som utsatts för våld i nära relation. Sjuksköterskor erfar en frustration när kvinnor inte tar emot hjälp eller återvänder till våldsamma relationer (Aregger Lundh et al., 2023; Duchesne et al., 2023; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Rahmqvist et al., 2019).

2.2.2 Sjuksköterskors kompetens vid våld i nära relation

Kompetensen hos sjuksköterskor inom våld i nära relation påverkas av utbildning, kunskap och erfarenhet (Alshammari et al., 2018; Aregger Lundh et al., 2023; Aydin & Karaçar, 2025; Briones-Vozmediano et al., 2022; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Gandhi et al., 2018; Li et al., 2024; Renner et al., 2019; Ruiz-Fernández et al., 2022).

Totalt 13,2 % (N = 43) av sjuksköterskor hade genomgått en utbildning inom våld i nära relation. Denna grupp uppvisade högre värden på självskattningsskalor avseende beredskap och upplevd trygghet i bemötandet av kvinnor som utsatts för våld i nära relation (Aydin & Karaçar, 2025). Utbildning är associerad med ökad kompetens hos sjuksköterskor samt till erfarenheter av ökad trygghet i bemötandet med kvinnor som utsatts för våld i nära relation (Aydin & Karaçar, 2025; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Duchesne et al., 2023; Gandhi et al., 2018; Renner et al., 2019; Ruiz-Fernández et al., 2022).

Brist på kompetens hos sjuksköterskor är associerad med att våld i nära relation inte identifieras eller att åtgärder uteblir, vilket kan påverka patientens möjlighet till stöd (Alshammari et al., 2018; Aregger Lundh et al., 2023; Li et al., 2024). Vidare uppger 27 % (N=22) av sjuksköterskor oro inför samtal om våld i nära relation och 31 % (N=26) uppger tveksamhet eller ovilja att delta i sådana samtal (Gandhi et al., 2018).

Sjuksköterskor behöver ha kompetens att identifiera både fysiska och psykiska tecken på våld i nära relation, kommunicera på ett empatiskt och icke-dömande sätt samt känna till relevanta riktlinjer och stödresurser (Aregger Lundh et al., 2023; Briones-Vozmediano et al., 2022; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Gandhi et al., 2018; Li et al., 2024). Trots detta erfar sjuksköterskor tveksamheter i hur de ska bemöta kvinnor som utsatts för våld i nära relation (Aydin & Karaçar, 2025; Briones-Vozmediano et al., 2022; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Duchesne et al., 2023; Gandhi et al., 2018; Li et al., 2024; Ruiz-Fernández et al., 2022).

2.2.3 Organisatoriska förutsättningar i vården

Organisatoriska och strukturella förutsättningar inom hälso- och sjukvården påverkar hur våld i nära relation identifieras och hanteras. Förutsättningarna i vårdarbetet påverkas bland annat av arbetsbelastning, tidsramar och resursnivåer, vilket kan begränsa möjligheterna till samtal och stödinsatser (Aregger Lundh et al., 2023; Briones-Vozmediano et al., 2022; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Duchesne et al., 2023; Li et al., 2024; Rahmqvist et al., 2019). Även avsaknad av rutiner och riktlinjer påverkar hur arbetet organiseras och hur situationer vid misstänkt våld i nära relation hanteras (Alshammari et al., 2018; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Li et al., 2024; Rahmqvist et al., 2019; Renner et al., 2019). Detta bekräftas i

sjuksköterskors erfarenheter av behov av tydligare rutiner och vägledning i det kliniska arbetet (Briones-Vozmediano et al., 2022; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Gandhi et al., 2018; Li et al., 2024).

Möjligheterna att identifiera våld i nära relation påverkas av hur vårdmiljön är organiserad, där möjligheter till enskilda samtal och tillgång till privata rum har betydelse för om frågor om utsatthet kan ställas och besvaras på ett tryggt sätt (Li et al., 2024; Duchesne et al., 2023; Ruiz-Fernández et al., 2022). Kontinuitet i vården och etablerade vårdrelationer framkommer som ytterligare faktorer som påverkar förutsättningarna för att uppmärksamma och följa upp fall vid våld i nära relation (Briones-Vozmediano et al., 2022; Ruiz-Fernández et al., 2022).

Även kommunikativa förutsättningar i vårdmötet påverkas av organisatoriska resurser inom hälso- och sjukvården. Bristande tillgång till tolk eller andra språkliga stödresurser kan försvåra kommunikationen mellan kvinnor och sjuksköterskor (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017). Utöver detta sker samverkan mellan hälso- och sjukvården, socialtjänst och polis i arbetet vid våld i nära relation, vilket skapar möjligheter till ett samordnat omhändertagande för kvinnor som utsatts för våld i nära relation (Briones-Vozmediano et al., 2022; Li et al., 2024).

2.3 Vårdvetenskapligt perspektiv

Valet av Katie Erikssons caritativa vårdteori grundas i hennes syn på människan som en helhet samt vikten av att vårda med kärlek och omsorg (Eriksson, 2018). Teorin bedöms vara relevant för arbetet eftersom den erbjuder ett vårdvetenskapligt perspektiv på vårdande handlingar, bemötande och lidande. Därmed kan teorin bidra till en förståelse för hur bemötandet inom hälso- och sjukvården kan erfaras av kvinnor som utsatts för våld i nära relation. I följande avsnitt beskrivs de delar av den caritativa vårdteorin som är relevanta för detta arbete.

2.3.1 Katie Erikssons caritativa vårdteori

Människan beskrivs som en helhet bestående av kropp, själ och ande. Hälsa förstås som ett tillstånd där det finns balans mellan dessa delar. I teorin definieras patienten som en lidande människa, där lidandet beskrivs som en utgångspunkt för vårdandet. Vårdrelationen beskrivs som helig och kännetecknas av respekt, tillit och lyhördhet (Eriksson, 2018).

Det caritativa vårdandet utgör grunden i Erikssons vårdvetenskap. Begreppet caritas avser kärlek och barmhärtighet och innebär att vårdandet präglas av en etisk hållning där det tas hänsyn till patientens värdighet och integritet. Målet med vårdandet är inte enbart att bota sjukdom och lindra fysiska symtom, utan även att lindra lidande och främja hälsa utifrån hela människan. Lidande beskrivs som något som kan visa sig på olika sätt och delas in i sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande handlar om lidande kopplat

till sjukdom och behandling, vårdlidande uppstår i samband med vårdsituationen, och livslidande hänger ihop med människans livssituation (Eriksson, 2018).

Det caritativa vårdandet visar sig i vårdrelationen som präglas av närvaro, tillit och öppenhet. I vårdandet blir patienten bemött som en människa och inte enbart som en sjukdom vilket innebär att bli sedd, lyssnad på och tagen på allvar. Relationen är inte jämlik eftersom vårdaren har ett större ansvar för patienten. Vårdandet beskrivs som en naturlig mänsklig handling och en kärleksgärning, där uttryck som omsorg och medmänsklighet är viktiga (Eriksson, 2018).

2.4 Lagar och riktlinjer

Vårdpersonals professionella ansvar regleras av lagar och riktlinjer som vägleder arbetet i mötet med patienter. Nedan redogörs för de bestämmelser som är relevanta vid vård av kvinnor som utsatts för våld i nära relation.

2.4.1 Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor

Sjuksköterskor utgör en stor del av vårdpersonalen och har ofta den första kontakten med patienter. Enligt kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2024) ska sjuksköterskor arbeta personcentrerat, visa respekt för patientens integritet samt främja trygghet och delaktighet i vårdsituationen. Sjuksköterskan har även ett ansvar att uppmärksamma patienter som är i behov av stöd och skydd.

2.4.2 Patientlagen

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska vården ges med respekt och värna om den enskilda människans värdighet. Patienten ska även få omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och vara trygg för patienten. Patientlagen (SFS 2014:821) betonar även vikten av att patienten ska känna sig delaktig, få tydlig information och ge samtycke till den vård som utförs.

2.4.3 Socialstyrelsens handbok vid våld i nära relation

Kvinnor som utsatts för våld i nära relation kan ha svårt att öppna upp sig för sjukvården om vad de varit med om. Många kvinnor söker vård av andra symtom än våldet i sig, då de inte alltid uppfattar sambandet mellan deras hälsoproblem och det våld som de blivit utsatta för. Det är därför viktigt att vårdpersonal vid misstanke om våld i nära relation tar sig tid i mötet med patienten, visar empati, lyhördhet och erbjuder en trygg vårdmiljö (Socialstyrelsen, 2023).

2.5 Problemformulering

Det finns flera lagar och riktlinjer som reglerar vårdpersonals ansvar i vårdmötet såsom krav på god, säker och personcentrerad vård. Tidigare forskning visar dock att det finns kunskapsbrist hos sjuksköterskor samt organisatoriska brister som påverkar hur kvinnor som utsatts för våld i nära relation bemöts inom hälso- och sjukvården. Eftersom hälso- och sjukvården ofta utgör en viktig kontaktpunkt för dessa kvinnor finns det behov av ökad kunskap om deras erfarenheter av bemötandet. Brister i vårdmötet kan samtidigt försvåra möjligheterna att uppmärksamma behov och erbjuda adekvat stöd.

Enligt Katie Erikssons caritativa vårdteori ska vårdmötet präglas av tillit, närvaro, respekt och barmhärtighet, där lidande lindras genom ett vårdande förhållningssätt. I tidigare forskning beskriver sjuksköterskor att dessa ideal inte alltid uppnås i praktiken vid mötet med kvinnor som utsatts för våld i nära relation.

Samtidigt är kunskapen begränsad om hur kvinnor själva erfar bemötandet från vårdpersonal inom hälso- och sjukvården vid våld i nära relation. Det finns därför behov av att belysa kvinnors erfarenheter för att öka förståelsen för vilka faktorer som främjar eller hindrar ett vårdande möte. En sådan kunskap kan bidra till utvecklingen av ett mer personcentrerat vårdande samt stärka vårdpersonalens förutsättningar att möta kvinnors behov.

3 SYFTE

Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av bemötande från vårdpersonal inom hälso- och sjukvården vid våld i nära relation.

4 METOD

Till detta arbete har en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2022) valts som metod. Metoden är särskilt lämplig när syftet är att kartlägga och sammanställa kunskap inom ett område där det finns befintlig forskning samt där en samlad översikt kan bidra till ökad förståelse. I detta fall är målet att få en fördjupad förståelse för kvinnors erfarenheter av bemötande från vårdpersonal inom hälso- och sjukvården vid våld i nära relation.

En allmän litteraturöversikt är inte begränsad till en specifik studiedesign, vilket möjliggör inkludering av både kvalitativa och kvantitativa studier för att belysa olika aspekter av ett fenomen. Detta är relevant i relation till arbetets syfte, eftersom erfarenheter av bemötande kan vara subjektiva och uttryckas på olika sätt i olika studier.

Till skillnad från mer avgränsade översikter, såsom systematiska översikter eller metasynteser, syftar den allmänna litteraturöversikten inte till att väga evidens, utan till att identifiera återkommande mönster, teman och potentiella kunskapsluckor.

Arbetet har genomförts i flera steg: val av relevanta sökord, databassökningar, urval av relevanta artiklar och systematisk analys av innehållet. I detta avsnitt beskrivs de metodiska processer som genomförts samt de kriterier som använts för att välja ut och analysera artiklar.

4.1 Datainsamling och urval

Analysen baseras på artiklar insamlade från två databaser: CINAHL plus och PubMed. CINAHL Plus valdes på grund av sin inriktning mot omvårdnad och vårdvetenskap medan PubMed användes då den är en omfattande databas inom medicinsk och hälsorelaterad forskning (Östlundh, 2022). Dessa egenskaper gör dem relevanta för att identifiera evidensbaserade artiklar om patienters vårderfarenheter och sjukhusvård.

För att besvara arbetets syfte fastställdes inklusions- och exklusionskriterier innan litteratursökningarna genomfördes. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle undersöka kvinnor utsatta för våld i nära relation samt deras erfarenheter av bemötandet från vårdpersonal inom hälso- och sjukvården. Endast vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ eller kvantitativ ansats inkluderades. Exklusionskriterierna var studier som fokuserade på barn, tonåringar eller män samt metaanalyser och litteraturöversikter.

För att säkerställa relevans och kvalitet tillämpades följande avgränsningar i sökningarna: artiklarna skulle vara peer reviewed, skrivna på engelska och vara publicerade inom en femårsperiod. På grund av ett begränsat antal relevanta sökträffar beslutade författarna att utöka tidsintervallet till tio år, vilket innebar att sökningarna omfattade åren mellan 2016 och 2026. Peer reviewed innebär att artiklarna granskats av oberoende experter innan publicering i syfte att säkerställa vetenskaplig kvalitet (Östlundh, 2022). Eftersom PubMed saknar en direkt filterfunktion för peer reviewed granskades artiklarna i stället genom Ulrichsweb (2026), vilket enligt Östlundh (2022) kan användas för att säkerställa att artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Artiklar skrivna på engelska underlättade tolkningen av resultaten och avgränsningen mellan åren 2016 och 2026 valdes för att begränsa sökträffarna till aktuell forskning.

När avgränsningarna fastställs identifieras nyckelord som speglar syftet, vilket utgör grunden för databassökningar (Polit & Beck, 2021; Östlundh, 2022). Tre nyckelord valdes ut: *kvinnors erfarenheter, inom hälso- och sjukvården* samt *våld i nära relation*. Dessa nyckelord översattes till engelska och kombinerades för att bilda söksträngar i databaserna. De fullständiga sökstrategierna och sökresultaten redovisas i bilaga A. Nyckelorden kompletterades sedan med synonymer för att skapa ytterligare söksträngar för att hitta fler relevanta artiklar till arbetet. Under arbetets gång kompletterades sökorden ytterligare med termer som identifierades genom läsandet av andra artiklar.

Sökorden kombinerades genom boolesk sökteknik där operatorerna AND och OR användes, vilket är ett systematiskt sätt att kombinera olika sökord med varandra. Operatorn NOT kan även användas för att exkludera söktermer (Hellberg & Karlsson, 2023; Polit & Beck, 2021; Östlundh, 2022). Vid sökningar där träffbilden blev för bred användes operatorn NOT tillsammans med arbetets exklusionskriterier för att smalna av träffbilden.

Vid söktermer där det fanns misstanke om många olika böjningsformer användes trunkering, vilket innebär att en asterisk placeras vid ordstammen utan mellanslag (Hellberg & Karlsson, 2023; Polit & Beck, 2021; Östlundh, 2022). Trunkering användes på söktermerna *experience* och *health care* i CINAHL plus för att inkludera olika böjningsformer och därmed bredda träffbilden.

I sökningarna användes även frassökning, vilket genomförs genom att sätta citattecken runt två eller flera ord som ska behandlas som en sammanhållen fras. Detta innebär att orden måste förekomma i exakt den angivna ordningsföljden i databasen, vilket minskar risken för irrelevanta träffar och ökar precisionen i sökningen (Hellberg & Karlsson, 2023). Detta användes på sökorden *domestic violence, emergency departments samt intimate partner violence*.

Urvalet av artiklar genomfördes med hjälp av det så kallade helikopterperspektivet enligt Friberg (2022), vilket innebar att relevanta artiklars abstrakt lästes för att få en övergripande förståelse av innehållet samt bedöma dess relevans i relation till arbetets syfte. Sökningar i CINAHL plus genomfördes med sökorden *”domestic violence”, ”emergency departments”, experience*, healthcare*, ”intimate partner violence”, IPV* samt *patient*. Sökningarna i PubMed genomfördes med sökorden *abuse, domestic violence, experiences, healthcare, healthcare professionals, help-seeking, intimate partner, qualitative study, victim of intimate partner violence, violence* samt *women*.

Totalt genomfördes sju sökningar i databaserna som gav utfall till arbetet (se bilaga A). Resultatet blev 641 träffar, samtliga titlar granskades, 173 abstracts lästes för att bedöma relevans i relation till studiens syfte (se bilaga A). Därefter valdes 13 artiklar ut för kvalitetsgranskning. Då detta arbete fokuserar på erfarenheter använde sig majoriteten av artiklarna (N=10) av kvalitativ ansats. För att inkludera så många relevanta erfarenheter som möjligt inkluderades även två kvantitativa studier.

Varje artikel granskades sedan utifrån nio utvalda granskningsfrågor, vilka utformats av författarna med inspiration från Friberg (2022). De använda granskningsfrågorna samt resultatet av kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga B. Frågorna valdes för att fokusera på de aspekter av vetenskaplig kvalitet som är mest relevanta för arbetets syfte samt att de kunde besvaras på ett enhetligt sätt. Frågorna omformulerades av författarna så att de kunde besvaras med ja eller nej, där en poäng står för ja och noll poäng för nej. Artiklar som erhöll mellan sju och nio poäng ansågs vara av hög vetenskaplig kvalitet. Tolv av artiklarna erhöll minst åtta av nio möjliga poäng. En artikel fick endast sex av nio möjliga poäng och exkluderades därför ur arbetet. Samma granskningsmall användes för både kvalitativa och kvantitativa studier eftersom granskningen fokuserade på övergripande vetenskapliga kvalitetsaspekter, såsom tydligt syfte, metodbeskrivning, urval, etiska överväganden och resultat. Eftersom endast två av de inkluderade studierna hade kvantitativ ansats bedömdes

en gemensam redovisning vara mer ändamålsenlig än separata tabeller. Resultatet av kvalitetsgranskningen redovisades därför i en gemensam tabell.

4.2 Genomförande och analys

Till detta arbete har en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2022) använts som metod. En allmän litteraturöversikt syftar till att sammanställa och beskriva det aktuella kunskapsläget inom ett specifikt omvårdnadsområde eller ett problem som är relevant för sjuksköterskors arbete. Det innebär att tidigare forskning granskas för att skapa en förståelse för vad som redan har undersökts.

Analysen av de vårdvetenskapliga artiklarna genomfördes i flera steg. Inledningsvis lästes artiklarna igenom flera gånger av författarna, både individuellt och gemensamt för att skapa en helhetsförståelse av innehållet. Därefter färgkodades det material i artiklarna som var relevant i förhållande till arbetets syfte. När materialet hade bearbetats individuellt jämfördes det kodade materialet gemensamt för att skapa teman till resultatet. Likheter och skillnader i studiernas syfte, metod och resultat dokumenterades för att presenteras i resultatdelen i enlighet med Friberg (2022). I nästa steg sammanställdes viktiga aspekter från varje artikel, såsom syfte, metod och resultat, i en översiktstabell (se bilaga C). Denna strukturering bidrog till en ökad överblick och underlättade den fortsatta analysen.

4.3 Etiska överväganden

Eftersom arbetet bygger på redan publicerade artiklar, har ingen etisk prövning enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) varit nödvändig. Enligt Friberg (2022) är det viktigt att reflektera över etiska överväganden i litteraturbaserade studier, särskilt när det gäller val av källor och hanteringen av dessa. För att säkerställa korrekt och enhetlig referenshantering i arbetet följdes riktlinjerna i sjunde upplagan av American Psychological Association (2026).

Vid urvalet av artiklar har vikt lagts vid att inkludera studier som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och där det tydligt framgår att forskningen genomförts i enlighet med erkända etiska principer. Dessa omfattar bland annat informerat samtycke, respekt för anonymitet och konfidentialitet och att deltagarna har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande samt att den information som samlats in endast får användas för de syften som deltagarna blivit informerade om (Kjellström, 2023; Vetenskapsrådet, 2024). Dessa principer är särskilt viktiga i forskning som behandlar känsliga ämnen, eftersom risken att utsatta grupper kan skadas är påtaglig. Att använda etiskt granskade och ansvarsfullt genomförda källor utgör en viktig del i detta arbete. Alla artiklar som ingår i arbetet är skrivna på engelska, vid språklig osäkerhet användes Google Översätt (Google, 2026) som stöd för att minska risken för feltolkning av materialet.

Förförståelse kan påverka tolkningen av litteraturen, vilket har beaktats under arbetets gång. Enligt Friberg (2022) är medvetenhet om förförståelse viktig inom litteraturbaserad forskning, då tolkning av information ofta påverkas av tidigare erfarenheter och värderingar.

För att minska denna påverkan har en strävan efter objektivitet och en öppenhet för olika perspektiv upprätthållits. Detta har inkluderat en kontinuerlig granskning av egna antaganden samt en medvetenhet om känslomässiga och värderingsbaserade reaktioner på ämnet. Genom att hålla ett professionellt och kritiskt förhållningssätt till de valda artiklarna har en mer nyanserad och trovärdig översikt eftersträvats, vilket är av betydelse för att undvika att förförståelsen leder till partiskhet eller snedvridna tolkningar.

5 RESULTAT

Resultatet baserades på tolv vetenskapliga artiklar som uppfyllde arbetets inklusionskriterier. Av dessa hade tio kvalitativ ansats och två hade kvantitativ ansats. Artiklarna undersökte kvinnors erfarenheter av bemötande från vårdpersonal inom hälso- och sjukvården vid våld i nära relation. Likheter och skillnader i artiklarnas syften presenteras inledningsvis i löpande text och sammanfattas i *tabell 1*. Därefter presenteras likheter och skillnader i artiklarnas metoder i löpande text samt i *tabell 2*. Avslutningsvis redovisas likheter och skillnader i artiklarnas resultat.

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte

Majoriteten av syftena i de inkluderade artiklarna visade ett gemensamt fokus på erfarenheter av våld i nära relation i mötet med hälso- och sjukvården (Aregger Lundh et al., 2025; Dichter et al., 2021; Heron et al., 2022; Hollingdrake et al., 2023; McGarry & Hinsliff-Smith, 2021; Moore et al., 2025; Reeves & Humphreys, 2018; Swailes et al., 2017; Wallin Lundell et al., 2017). Trots denna gemensamma inriktning varierade studiernas syften beträffande vilka aspekter av erfarenheterna som undersöktes.

Flera syften fokuserade på erfarenheter av vårdmötet och bemötandet inom hälso- och sjukvården (McGarry & Hinsliff-Smith, 2021; Swailes et al., 2017; Wallin Lundell et al., 2017; Williams et al., 2020). Andra syften riktade istället fokus mot processen att berätta om våld i nära relation och de faktorer som påverkade detta, såsom hinder och möjliggörande omständigheter inom vårdkontexten (Heron et al., 2022; Swailes et al., 2017; Williams et al., 2020). Ett mer specifikt fokus i syftet återfanns i Olive (2017), där fokuset låg på kvinnornas emotionella reaktioner i samband med vårdkontakter efter våld i nära relation. Reeves och Humphreys (2018) fokuserade i stället på hur kvinnorna navigerade vård- och stödsystem efter erfarenheter av våld i nära relation.

Likheter framkom även avseende den kontext där erfarenheterna studerades. De flesta syften riktade sig mot erfarenheter inom hälso- och sjukvården i ett bredare perspektiv (Aregger Lundh et al., 2025; Heron et al., 2022; Hollingdrake et al., 2023; Hooker et al., 2020; McGarry & Hinsliff-Smith, 2021; Reeves & Humphreys, 2018; Swailes et al., 2017; Wallin Lundell et al., 2017; Williams et al., 2020). Vissa syften hade dock en mer avgränsad kontext.

Olive (2017) fokuserade exempelvis på erfarenheter från akutmottagningar som en specifik vårdkontext inom hälso- och sjukvården, medan Dichter et al. (2021) syftade till att belysa erfarenheter av vårdrelaterade stödinsatser vid våld i nära relation.

Skillnader framkom också i de målgrupper som syftena riktades mot. De flesta syften inkluderade kvinnor med erfarenhet av våld i nära relation generellt (Aregger Lundh et al., 2025; Dichter et al., 2021; Heron et al., 2022; Hollingdrake et al., 2023; McGarry & Hinsliff-Smith, 2021; Olive, 2017; Reeves & Humphreys, 2018; Swailes et al., 2017; Wallin Lundell et al., 2017; Williams et al., 2020). Två syften fokuserade däremot på specifika grupper av kvinnor. Moore et al. (2025) undersökte afroamerikanska kvinnors erfarenheter av våld i nära relation och kontakt med vård och rättsväsende, medan Hooker et al. (2020) studerade postpartumkvinnors hjälpsökande beteenden och erfarenheter av stöd från hälso- och sjukvården.

Sammanfattningsvis visar syftena en gemensam inriktning mot erfarenheter av våld i nära relation inom hälso- och sjukvården, samtidigt som de skiljer sig åt beträffande fokusområde, vårdkontext och målgrupp. En översikt av artiklarnas syften, målgrupper, kontext och fokus presenteras i *tabell 1*.

Tabell 1: Likheter och skillnader i artiklarnas syfte

Författare	Syfte	Målgrupp	Kontext	Fokus
Aregger Lundh et al.	Investigate experiences and expectations in the care of adults who had experienced IPV (Intimate partner violence)	Vuxna som har erfarenhet av våld i nära relation	Vård av vuxna	Erfarenheter och förväntningar i vården
Dichter et al.	To understand IPV survivors' experiences with and perspectives on health care-connected IPV services	Överlevare av våld i nära relation	Hälso- och sjukvårds relaterade tjänster	Erfarenheter av vårdrelaterade insatser vid våld i nära relation
Heron et al.	To explore victims' perceptions and experiences of disclosing to health care services and to identify barriers and facilitators of disclosure within an ethnically diverse UK sample	Offer för våld i nära relation	Hälso- och sjukvård	Erfarenheter av att berätta om sin utsatthet
Hollingdrake et al.	To explore the perceptions of women with lived experience of domestic and family violence on accessing	kvinnor med erfarenhet av våld i	Hälso- och sjukvård	Erfarenheter av att söka

	healthcare and to identify how nurses can facilitate and support women experiencing domestic and family violence to receive the care they need	nära relation/familjevåld		vård vid våld i nära relation
Hooker et al.	To identify help-seeking behaviours and perceived helpfulness of Australian healthcare services used by postpartum women and examine possible differences in help-seeking behaviour and perceived helpfulness between women exposed to IPV and women not exposed to IPV	Postpartum kvinnor med eller utan erfarenheter av våld i nära relation	Hälso- och sjukvård	Hjälpsökande och upplevt stöd från hälso- och sjukvårdstjänster vid våld i nära relation
McGarry & Hinsliff-Smith	To explore women's experiences of healthcare encounters following domestic violence and abuse (DVA), presented as personal narratives	Kvinnor som utsatts för våld i nära relation	Hälso- och sjukvård	Kvinnors erfarenheter i bemötandet inom vården vid våld i nära relation
Moore et al.	To explore African American women's experiences with IPV and navigation of health care and law enforcement after experiences of violence	Afroamerikanska kvinnor med erfarenhet av våld i nära relation	Hälso- och sjukvård samt rättsväsende	Erfarenheter av våld i nära relation, kontakt med hälso- och sjukvård samt rättsväsende
Olive, P.	To explore women's emotional and affective responses following an incident of intimate partner violence experienced during emergency department attendances	Kvinnor som utsatts för våld i nära relation	Akutmottagning	Kvinnors emotionella reaktioner i samband med vårdmöte
Reeves & Humphreys	To develop knowledge on women survivors' healthcare experiences and strategies	Kvinnor som överlevt våld i nära relation	Hälso- och sjukvård	Erfarenheter av vård och strategier för att navigera vården
Swailes et al.	To examine outcomes of IPV screening, including use of guideline-concordant discussion topics and	Kvinnor med erfarenhet av våld i nära relation som haft kontakt med	Hälso- och sjukvård	Erfarenheter av bemötandet och samtal

	interventions, as well as patient perception of the encounters	hälso- och sjukvård det senaste året		
Wallin Lundell et al.	To describe how women in Mexico who have suffered from gender-based violence experience their encounters with health care professionals	Kvinnor utsatta för könsbaserat våld	Hälso- och sjukvård	Erfarenheter av bemötande inom vården
Williams et al.	To better understand victims' perspectives regarding decisions to disclose gender-based violence, namely, intimate partner violence (IPV) and human trafficking, to health care providers and what outcomes matter to them when discussing these issues with their provider	Offer för könsbaserat våld, inklusive våld i nära relation (IPV) och människohandel	Hälso- och sjukvård	Vad som är relevant i bemötandet för att offren ska välja att berätta om sin utsatthet

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod

Majoriteten av de inkluderade studierna hade en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer var den vanligaste datainsamlingsmetoden (Aregger Lundh et al., 2025; Dichter et al., 2021; Heron et al., 2022; Moore et al., 2025; Olive, 2017; Reeves & Humphreys, 2018; Wallin Lundell et al., 2017; Williams et al., 2020). Två studier använde fokusgrupper som datainsamlingsmetod, men genomförandet och analysen skiljde sig åt. Hollingdrake et al. (2023) använde fokusgrupper med öppna frågor samt ljudinspelning medan McGarry och Hinsliff-Smith (2021) kombinerade fokusgrupper med fältanteckningar då inget samtycke till ljudinspelning getts av deltagarna.

Fem av de kvalitativa studierna använde sig av kvalitativ innehållsanalys (Aregger Lundh et al., 2025; Dichter et al., 2021; Heron et al., 2022; Reeves & Humphreys, 2018; Williams et al., 2020). Tre av studierna använde sig av tematisk analys (Hollingdrake et al., 2023; Moore et al., 2025; Olive, 2017). En studie använde induktiv innehållsanalys (Wallin Lundell et al., 2017). Gemensamt för de studier som använde kvalitativ innehållsanalys eller tematisk analys var att data bearbetades genom kodning och kategorisering för att identifiera mönster och teman i materialet (Aregger Lundh et al., 2025; Dichter et al., 2021; Heron et al., 2022; Hollingdrake et al., 2023; Moore et al., 2025; Olive, 2017; Reeves & Humphreys, 2018; Williams et al., 2020). En metodologisk avvikelse återfanns hos McGarry och Hinsliff-Smith (2021), som använde en narrativ analys där resultaten presenterades som sammanhängande personliga berättelser.

Två av studierna använde sig av kvantitativ ansats och genomfördes som tvärsnittsstudier med enkätundersökningar som datainsamlingsmetod, där både slutna och öppna frågor ingick (Hooker et al., 2020; Swailes et al., 2017). De kvantitativa studierna skilde sig från de kvalitativa genom att de fokuserade på att beskriva förekomst och samband med hjälp av deskriptiv analys där antal och procent beräknades och resultaten presenterades i tabeller.

Det inkluderade materialet representerade flera olika länder, däribland Australien, Mexico, Storbritannien, Sverige och USA (Aregger Lundh et al., 2025; Dichter et al., 2021; Heron et al., 2022; Hollingdrake et al., 2023; Hooker et al., 2020; McGarry & Hinsliff-Smith, 2021; Moore et al., 2025; Olive, 2017; Reeves & Humphreys, 2018; Swailes et al., 2017; Wallin Lundell et al., 2017; Williams et al., 2020). Några tydliga mönster mellan studiernas geografiska kontext och val av metodansats kunde inte identifieras. I samtliga länder återfanns huvudsakligen kvalitativa studier där intervjuer användes som datainsamlingsmetod. En översikt av artiklarnas metoder presenteras i *tabell 2*.

Tabell 2: Likheter och skillnader i artiklarnas metod

Författare	Ansats	Datainsamlingsmetod	Dataanalysmetod	Land
Aregger Lundh et al.	Kvalitativ	Semistrukturerade intervjuer	Kvalitativ innehållsanalys	Sverige
Dichter et al.	Kvalitativ	Semistrukturerade intervjuer	Kvalitativ innehållsanalys	USA
Heron et al.	Kvalitativ	Semistrukturerade intervjuer	Kvalitativ innehållsanalys	Storbritannien
Hollingdrake et al.	Kvalitativ	Fokusgrupper med 8 öppna frågor	Tematisk analys	Australien
Hooker et al.	Kvantitativ	Tvärsnittstudie, enkät	Kvantitativ deskriptiv analys	Australien
McGarry & Hinsliff-Smith	Kvalitativ	Fokusgrupper och fältanteckningar (ingen ljudinspelning)	Narrativ analys	Storbritannien
Moore et al.	Kvalitativ	Semistrukturerade intervjuer	Tematisk analys	USA
Olive, P.	Kvalitativ	Semistrukturerade intervjuer	Tematisk analys	Storbritannien
Reeves & Humphreys	Kvalitativ	Semistrukturerade intervjuer	Kvalitativ innehållsanalys	USA
Swailes et al.	Kvantitativ	Tvärsnittstudie, enkät	Kvantitativ deskriptiv analys	USA

Wallin Lundell et al.	Kvalitativ	Semistrukturerade intervjuer	Induktiv innehållsanalys	Mexiko
Williams et al.	Kvalitativ	Semistrukturerade intervjuer	Kvalitativ innehållsanalys	USA

5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat

Nedan presenteras likheter och skillnader i artiklarnas resultat under fyra identifierade teman: att våga berätta, synliggörandet av våld i nära relation, betydelsen av organisatoriska förutsättningar samt bemötandets konsekvenser för framtida vårdkontakt.

5.3.1 Att våga berätta

Återkommande i kvinnornas erfarenheter var att vårdpersonalens bemötande kunde påverka deras benägenhet att berätta om våld i nära relation. Även rädsla kopplad till vårdpersonalens reaktioner såsom oro för att behöva skiljas från sina barn påverkade hur kvinnorna uppfattade bemötandet och vad de valde att berätta (Dichter et al., 2021; Heron et al., 2022; McGarry & Hinsliff-Smith, 2021; Williams et al., 2020).

Möjligheten att berätta om våld i nära relation påverkades även av i vilken grad vårdmötet uppfattades som tryggt. Ett tryggt, lyhört och uppmärksamt bemötande beskrevs som avgörande för om kvinnorna vågade dela sina erfarenheter av våld i nära relation (Aregger Lundh et al., 2025; Heron et al., 2022; Hollingdrake et al., 2023; McGarry & Hinsliff-Smith, 2021). Även kroppsspråket och små signaler från vårdpersonalen var av betydelse för hur bemötandet erfors (Aregger Lundh et al., 2025; Heron et al., 2022; Hollingdrake et al., 2023; McGarry & Hinsliff-Smith, 2021; Olive, 2017; Reeves & Humphreys, 2018; Wallin Lundell et al., 2017; Williams et al., 2020).

Erfarenheter av tillit till vårdpersonalen framkom som en viktig del av bemötandet och påverkade kvinnornas möjligheter att våga berätta om våld i nära relation (Aregger Lundh et al., 2025; Heron et al., 2022; Hollingdrake et al., 2023; McGarry & Hinsliff-Smith, 2021; Reeves & Humphreys, 2018; Wallin Lundell et al., 2017; Williams et al., 2020). Vidare identifierades variationer i kvinnornas erfarenheter av bemötandet i vårdmötet. När vårdpersonalen erfors som lugna, tog sig tid och förklarade situationen beskrevs bemötandet som stödjande vilket gjorde att de var mer benägna till att våga berätta. I kontrast beskrevs det att stress, bristande engagemang samt ett fokus på enbart fysiska skador påverkade bemötandet negativt och minskade kvinnornas förutsättningar att våga berätta om våld i nära relation (Aregger Lundh et al., 2025; Olive, 2017; Wallin Lundell et al., 2017; Williams et al., 2020).

5.3.2 Synliggörande av våld i nära relation

Misstankar om våld i nära relation följdes inte alltid upp av vårdpersonalen vilket begränsade möjligheten att synliggöra våldet och erbjuda stödinsatser (Aregger Lundh et al., 2025; Moore et al., 2025). Det framkom att kvinnorna som utsatts för våld i nära relation i högre grad kom i kontakt med flera vårdtjänster där vårdpersonalens bemötande förekom. Bland de kvinnorna som utsatts för våld i nära relation hade 45,2 % (N=75) besökt akutmottagningar jämfört med 34,6 % (N=795) av de icke utsatta kvinnorna. Även kontakt med hemsjukvård var vanligare bland kvinnorna som utsatts för våld i nära relation, 36,6 % (N=60) jämfört med 20,6 % (N=471) (Hooker et al., 2019). I de fall där våld i nära relation faktiskt uppmärksammades berättade flera av kvinnorna om erfarenheter av vårdpersonalens bemötande där deras skador avfärdades eller bagatelliserades, vilket beskrevs leda till frustration och en känsla av att inte bli trodda på i vårdmötet (McGarry & Hinsliff-Smith, 2021; Reeves & Humphreys, 2018).

Om frågor om våld i nära relation ställdes behövde de vara varsamt formulerade och anpassade till kvinnornas emotionella tillstånd, särskilt i situationer präglade av chock eller trauma. Snabba eller otydliga frågor kunde utgöra hinder för vårdpersonalens möjlighet att identifiera och synliggöra våld i nära relation (Aregger Lundh et al., 2025; Olive, 2017). Av kvinnorna som pratade om våld i nära relation med vårdpersonalen rapporterade 28,5 % (N=72,1) att de var mycket nöjda med bemötandet i samtalet, 27,5 %(N=69,6) av kvinnorna var mycket bekväma under samtalet. Samtidigt uppgav 5 % (N=12,6) att de var något obekväma och 2 % (N=5) att de var mycket obekväma. Av de kvinnorna som inte hade diskuterat våld i nära relation med vårdpersonalen angav 4 % (N=10,1) att de hade velat prata om detta, dock inte fått möjlighet (Swailes, Lehman & McCall-Hosenfeld, 2017).

5.3.3 Betydelsen av organisatoriska förutsättningar

Kvinnorna erfor brist på tid i bemötandet av vårdpersonalen, vilket påverkade deras erfarenheter av vårdpersonalens bemötande negativt, då det erfors som stressat och utan utrymme för emotionellt stöd. Flera av kvinnorna beskrev erfarenheter av att bemötandet präglades av att vårdpersonalen behövde prioritera andra arbetsuppgifter vilket bidrog till erfarenheter av att samtalet inte fick tillräckligt med utrymme (Heron et al., 2022; McGarry & Hinsliff-Smith, 2021; Olive, 2017; Wallin Lundell et al., 2017; Williams et al., 2020). Vissa av kvinnorna beskrev dock att det inte var samtalets längd som var avgörande, utan att vårdpersonalens förmåga att se och bekräfta dem i stunden bidrog till positiva erfarenheter av bemötandet (Wallin Lundell et al., 2017). Vissa av kvinnorna erfor däremot att vårdpersonalens begränsade tid signalerade att deras erfarenheter av våld i nära relation inte prioriterades, vilket påverkade bemötandet negativt (Heron et al., 2022).

Vidare beskrev kvinnorna att vårdpersonalens bemötande i miljöer utan enskildhet och skyddade samtalsutrymmen erfors som otryggt, vilket försvårade deras möjligheter att berätta om sin situation. Detta inkluderade vårdmiljöer där samtal riskerade att avbrytas eller där andra personer kunde befinna sig i närheten, vilket påverkade vårdpersonalens möjlighet att ge ett ostört och sammanhållet bemötande i vårdmötet. (Aregger Lundh et al.,

2025; Heron et al., 2022; Hollingdrake et al., 2023; McGarry & Hinsliff-Smith, 2021; Olive, 2017).

5.3.4 Bemötandets konsekvenser för framtida vårdkontakt

Kvinnornas erfarenheter visade att vårdpersonalens bemötande hade betydelse för deras fortsatta vårdsökande. Negativa erfarenheter, såsom att inte bli trodd eller lyssnad på, beskrevs leda till minskad tillit till hälso- och sjukvården (Moore et al., 2025; Wallin Lundell et al., 2017). Vidare beskrevs även att bristande kunskap och förståelse hos vårdpersonalen påverkade bemötandet. Kvinnorna erfor att de ibland fick råd som var otillräckliga eller inte anpassade till deras situation vilket medförde en ovilja att söka vidare vård (Dichter et al., 2021; Hollingdrake et al., 2023; Olive, 2017).

Vid ett positivt bemötande, präglat av lyhördhet, empati och bekräftelse, beskrev kvinnorna däremot en ökad tillit samt en större benägenhet att åter söka vård (Hollingdrake et al., 2023; Reeves & Humphreys, 2018; Williams et al., 2020). Kvinnorna beskrev vidare att kommunikationen i samband med undersökningar och behandlingar hade betydelse för deras erfarenheter av hälso- och sjukvården och deras vilja att stanna kvar i fortsatt vårdkontakt. När syftet med undersökningar inte förklarades erfors situationen som skrämmande och bidrog till erfarenheter av rädsla och utsatthet. När kommunikationen däremot fungerade väl beskrev kvinnorna att oron minskade, samtidigt som de erfor en ökad delaktighet och känsla av kontroll (Reeves & Humphreys, 2018).

Öppna vårdmiljöer och bristande integritet påverkade kvinnornas erfarenheter av vårdpersonalens bemötande och erfors kunna leda till att kvinnorna valde att lämna vården trots behov av fortsatt hjälp (McGarry & Hinsliff-Smith, 2021; Olive, 2017). Vidare beskrev kvinnorna att brist på stöd och vägledning kunde innebära att de återvände till otrygga situationer utan tillräckliga verktyg för förändring (Dichter et al., 2021; McGarry & Hinsliff-Smith, 2021; Moore et al., 2025). Kvinnorna beskrev även erfarenheter av vad som skedde efter att de berättat om våld i nära relation i kontakt med vårdpersonalen, där berättandet inte alltid resulterade i åtgärder. Det framkom att 28% (N=27) av kvinnorna som samtalade om våld i nära relation med vårdpersonalen inte erbjöds någon åtgärd. Vidare erbjöds 58% (N=58) en åtgärd och 14% (N=13) erbjöds flera åtgärder. De åtgärder som kunde erbjudas var information om tillgängliga resurser, bekräftelse av kvinnornas erfarenheter av våld i nära relation, upprättande av säkerhetsplan, förskrivning av läkemedel samt uppföljning eller psykiatrisk kontakt, vilket framkom ha betydelse för kvinnornas fortsatta erfarenheter av hälso- och sjukvården (Swailes et al., 2017).

Slutligen beskrev kvinnorna att avsaknad av ett helhetsperspektiv i hälso- och sjukvården påverkade deras möjligheter att få stöd. Vårdmöten kunde avslutas utan att kvinnorna hade fått tillräcklig information om stödinsatser eller hjälp att etablera kontakt med relevanta verksamheter, vilket erfors begränsa deras möjligheter till fortsatt hjälp och förändring (Dichter et al., 2021; McGarry & Hinsliff-Smith, 2021; Moore et al., 2025).

6 DISKUSSION

I detta avsnitt diskuteras arbetets resultat, metod och etiska överväganden i relation till arbetets syfte. Diskussionen syftar till att sätta resultaten i ett större sammanhang och belysa hur dessa kan förstås utifrån tidigare forskning, teoretiska perspektiv samt metodologiska val. Vidare problematiseras styrkor och begränsningar i det genomförda arbetet.

6.1 Resultatdiskussion

Resultatdiskussionen är uppdelad i två delar och börjar med en diskussion av artiklarnas syfte och metod för att sedan i den andra delen diskutera artiklarnas resultat.

6.1.1 Diskussion av artiklarnas syfte och metod

De tolv inkluderade artiklarna hade syften som var relevanta i förhållande till arbetets syfte vilket var att belysa kvinnors erfarenheter av bemötandet från vårdpersonal inom hälso- och sjukvården vid våld i nära relation. Detta utgjorde en styrka då det möjliggjorde identifiering av återkommande mönster i analysen och bidrog till en ökad tydlighet i resultatet. Samtidigt kan denna likhet innebära en begränsning då andra typer av resultat om erfarenheter av bemötande riskerar att inte synliggöras i analysen. Enligt Henricson (2023) är det viktigt att syftet formuleras på ett tydligt sätt och ger en korrekt bild om vad som ska undersökas. Detta uppfylldes av artiklarna i detta arbete vilket gjorde dem relevanta för denna allmänna litteraturöversikt.

Det framkom dock variationer i artiklarnas syftesformuleringar. Vissa syften fokuserade specifikt på kvinnornas erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården, medan andra hade ett bredare perspektiv och behandlade övergripande vårderfarenheter eller organisatoriska aspekter av vårdsystemet. Denna variation kan ha bidragit till en större förståelse av erfarenheterna vilket kan ses som en styrka. Samtidigt innebär det en utmaning att jämföra studierna med varandra samt risken att tappa fokus från arbetets syfte under analysens gång ökade.

Majoriteten av de inkluderade artiklarna, tio av tolv använde sig av kvalitativ ansats. Detta kan betraktas som en styrka i relation till arbetets syfte, då kvalitativa metoder enligt Segersten (2022) möjliggör en fördjupad förståelse av individers erfarenheter. Samtidigt innebär kvalitativa studier ofta ett mindre urval vilket kan begränsa variationen bland deltagarna och därmed påverka resultatets överförbarhet (Henricson & Billhult, 2023). Två av de inkluderade artiklarna använde sig av kvantitativ ansats. Detta kan ses som en styrka genom att de möjliggjorde inkludering av ett större antal deltagare och därmed en bredare översikt av erfarenheter. Samtidigt kan det betraktas som en svaghet på grund av de begränsade möjligheterna till en djupare förståelse av erfarenheterna. Det kan uppstå svårigheter att tolka den numeriska datan på ett korrekt sätt vilket kan skapa utmaningar vid analysen och sammanställningen av resultatet.

Åtta av de tolv artiklar som analyserades använde sig av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Engström och Juuso (2023) är en styrka med denna metod att den ger en djupare förståelse för kvinnornas erfarenheter samtidigt som den ger utrymme för flexibilitet i intervjun. Dock genomfördes intervjuerna i dessa studier med mindre antal deltagare vilket kan påverka resultatets överförbarhet. Vid intervjuer som datainsamlingsmetod beskrivs även risker i form av påverkan då deltagarna riskerar att anpassa sina svar efter det som de tror att intervjuaren vill höra samt att det kan uppstå en maktposition mellan intervjuare och deltagare vilket Kjellström (2023) beskriver ställer krav på intervjuarens känslighet och etiskt kunnande.

Utöver intervjuer användes även fokusgrupper och enkäter som datainsamlingsmetoder i de inkluderade artiklarna, vilket bidrog till att belysa erfarenheter ur olika perspektiv. De kvantitativa studierna med enkäter som datainsamlingsmetod ger en mer övergripande bild med siffror och procentandelar, medan de kvalitativa studierna med fokusgrupper ger mer detaljerade beskrivningar av erfarenheter av bemötandet genom gruppdiskussioner. Kombinationen av olika metoder bidrar till variation i materialet och kan därför ses som en styrka. Däremot innebär det också en utmaning eftersom resultaten bygger på olika typer av data som ska analyseras.

Av de två artiklarna som använde sig av fokusgrupper valde en att inte spela in samtalen på grund av uteblivet samtycke. Informerat samtycke beskriver Kjellström (2023) som en process för att värna om deltagarna i forskningen. Då samtycke till inspelning av intervjuerna inte gavs samlades data i stället in via fältanteckningar. Detta kan påverka resultatets tillförlitlighet då forskarnas tolkningar och förförståelse kan påverka dokumentationen av samtalen. Henricson och Billhult (2023) menar att det är av vikt i kvalitativa studier att forskarna reflekterar och diskuterar över sin förförståelse då forskaren oftast är involverad i genomförandet av datainsamlingen. Att studierna genomfördes i olika länder kan bidra till en större förståelse av erfarenheterna. Samtidigt kan kulturella och organisatoriska skillnader i vårdsystem ha påverkat kvinnornas erfarenheter av bemötandet från vårdpersonalen.

Sammanfattningsvis bedömdes de inkluderade artiklarnas syften och metodval som relevanta i förhållande till arbetets syfte. Variationer i syfte, metodval och datainsamlingsmetoder innebar både bredd i materialet och utmaningar i analysarbetet.

6.1.2 Diskussion av artiklarnas resultat

Arbetets syfte var att belysa kvinnors erfarenheter av bemötande från vårdpersonal inom hälso- och sjukvården vid våld i nära relation. Resultatet visade att vårdpersonalens bemötande hade betydelse för kvinnornas erfarenheter av vårdmötet. Särskilt framträdande var betydelsen av trygghet, tillit och ett lyhört bemötande för att kvinnorna skulle våga berätta om våld i nära relation. Samtidigt framkom att stress, bristande engagemang och otillräcklig kunskap hos vårdpersonalen kunde leda till att kvinnorna inte kände sig hörda, trodda eller bekräftade i vårdmötet.

I temat *Att våga berätta* framkom att kvinnornas möjlighet att berätta om våld i nära relation påverkades av vårdpersonalens bemötande. När vårdpersonalen uppfattades som

närvarande, lyhörda och empatiska beskrev kvinnorna erfarenheter av trygghet och tillit, vilket gjorde att de lättare vågade berätta om sin situation. Däremot kunde stress, bristande engagemang och rädsla för negativa konsekvenser bidra till att kvinnorna avstod från att berätta om våld i nära relation. Fynden kan förstås utifrån Katie Erikssons caritativa vårdteori, där vårdandet beskrivs som en etisk handling präglad av respekt, närvaro och bekräftelse av människans värdighet (Eriksson, 2018). När vårdpersonalen visade empati, lyssnade och tog kvinnornas berättelser på allvar kan detta tolkas som ett caritativt förhållningssätt. Tidigare forskning beskriver samtidigt att sjuksköterskor kan erfara möten med kvinnor som utsatts för våld i nära relation som emotionellt krävande samt känna osäkerhet i hur situationerna bör hanteras (Aregger Lundh et al., 2023; Duchesne et al., 2023; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Rahmqvist et al., 2019). Resultatet visade att kvinnornas benägenhet att berätta om våld i nära relation inte enbart påverkades av om ämnet uppmärksammades, utan även av i vilken grad vårdrelationen präglades av trygghet och tillit. Även små signaler i bemötandet, såsom kroppsspråk, tonfall och närvaro påverkade om kvinnorna vågade berätta eller valde att tysta ned sina erfarenheter. Detta kan tolkas som att bemötande från vårdpersonal får en avgörande betydelse eftersom vårdmötet kan vara ett av få tillfällen där kvinnor som utsatts för våld i nära relation ges möjlighet att känna sig sedda, lyssnade på och trygga nog att berätta om sin situation.

I temat *Synliggörande av våld i nära relation* framkom att misstankar om våld i nära relation inte alltid följdes upp av vårdpersonalen. Kvinnorna beskrev även erfarenheter av att deras skador bagatelliserades eller att deras berättelser ifrågasattes när de försökte synliggöra våld i nära relation. Hur frågor kring våld i nära relation formulerades visade sig också ha betydelse för kvinnornas erfarenheter av vårdmötet. Varsamt formulerade frågor och ett anpassat bemötande ökade möjligheten att våld i nära relation synliggjordes, medan snabba eller otydliga frågor kunde utgöra ett hinder. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor erfar osäkerhet i bemötandet av kvinnor som utsatts för våld i nära relation samt att brist på kunskap, tydliga riktlinjer och organisatoriskt stöd kan försvåra arbetet (Briones-Vozmediano et al., 2022; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Gandhi et al., 2018; Li et al., 2024; Ruiz-Fernández et al., 2022). Detta kan vara bidragande orsaker till att våld i nära relation inte alltid synliggörs eller följs upp i vårdmötet. Resultatet kan även förstås i relation till sjuksköterskors kompetensbeskrivning, där det framgår att sjuksköterskor ska arbeta personcentrerat och identifiera behov av stöd och skydd (Svensk sjuksköterskeförening, 2024). Även Patientlagen (SFS 2014:821) och Socialstyrelsen (2023) betonar att vården ska präglas av respekt, trygghet och delaktighet. När kvinnorna beskrev erfarenheter av att inte bli trodda eller att deras situation inte uppmärksammades kan detta tolkas som att hälso- och sjukvården i vissa fall inte fullt ut motsvarar dessa krav. Resultatet kan tolkas som att bemötande från vårdpersonal, samt deras sätt att uppmärksamma och följa upp misstankar om våld i nära relation, har betydelse för kvinnors erfarenheter av att bli tagna på allvar i hälso- och sjukvården.

I temat *Betydelsen av organisatoriska förutsättningar* framkom att vårdmiljön och vårdens organisation hade betydelse för kvinnornas erfarenheter av bemötandet. Kvinnorna beskrev att tidsbrist, hög arbetsbelastning och avsaknad av enskilda samtalsutrymmen påverkade deras möjlighet att känna sig trygga i mötet med vårdpersonalen. Bemötandet erfors i flera fall som stressat och utan utrymme för emotionellt stöd. Samtidigt visade resultatet att

vårdmötets längd inte alltid var avgörande, utan att vårdpersonalens förmåga att visa närvaro och bekräftelse i sitt bemötande bidrog till positiva erfarenheter även under korta möten. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor erfar organisatoriska utmaningar såsom hög arbetsbelastning, tidsbrist och bristande resurser i arbetet med våld i nära relation (Aregger Lundh et al., 2023; Alshammari et al., 2018; Briones-Vozmediano et al., 2022; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Duchesne et al., 2023; Li et al., 2024; Rahmqvist et al., 2019). Resultatet kan därför förstås som att organisatoriska begränsningar inte enbart påverkar arbetsförutsättningar för vårdpersonal, utan även kvinnors möjlighet att känna trygghet och tillit i vårdmötet. Detta synliggör att bemötandet inte enbart kan förstås som en individuell kompetens hos vårdpersonal, utan även behöver analyseras i relation till vårdens organisatoriska förutsättningar.

I temat *Bemötandets konsekvenser för framtida vårdkontakt* framkom att kvinnornas erfarenheter av vårdpersonalens bemötande påverkade deras vilja att åter söka vård. Negativa erfarenheter av bemötandet ledde i flera fall till en ovilja att söka vidare hjälp. Kvinnorna beskrev även att brister i bemötandet, såsom bristande kommunikation i samband med undersökningar och behandlingar kunde leda till erfarenheter av rädsla och ökad utsatthet. När vårdpersonalen däremot förklarade situationen, visade förståelse och gav stöd erfor kvinnorna en ökad delaktighet och trygghet, vilket stärkte deras tillit till vården. Samtidigt identifierades att öppna vårdmiljöer och bristande integritet kunde leda till att kvinnorna valde att lämna vården trots behov av fortsatt hjälp. Kvinnorna beskrev även att avsaknad av stöd, vägledning och uppföljning kunde innebära att de återvände till otrygga situationer utan tillräckliga verktyg för förändring. Enligt Eriksson (2018) kan vårdlidande uppstå när patienten känner sig nonchalerad, kränkt eller inte tagen på allvar i vårdsituationen. Detta överensstämmer med kvinnornas erfarenheter av att inte bli trodda eller bekräftade i bemötandet av vårdpersonalen. Resultatet kan därför tolkas som att bemötandet inte enbart påverkar den aktuella vårdsituationen, utan även kvinnors framtida relation till vården och deras benägenhet att söka hjälp vid fortsatt utsatthet för våld i nära relation. Vidare beskrevs tillit som en viktig faktor i vårdmötet. Tillit skapades i interaktionen mellan kvinnorna och vårdpersonalen, samtidigt som den kunde vara skör och snabbt brytas. Även små signaler i bemötandet får därför betydelse, vilket synliggör den maktobalans som kan prägla vårdrelationen när kvinnor befinner sig i en särskilt sårbar position.

6.2 Metoddiskussion

Detta arbete genomfördes som en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2022). Då arbetets fokus var att belysa erfarenheter vilket enligt Friberg (2022) oftast beskrivs i kvalitativ forskning, övervägdes inledningsvis att enbart inkludera kvalitativ forskning och genomföra en litteraturstudie. För att skapa en bredare förståelse och inkludera flera typer av erfarenheter valdes dock en allmän litteraturöversikt, vilket möjliggjorde inkludering av både kvalitativa och kvantitativa studier (Friberg 2022).

En begränsning med metodvalet var att det vid litteratursökningen framkom få kvantitativa studier som svarade mot arbetets syfte. Ett metodbyte till litteraturstudie övervägdes. Den

allmänna litteraturöversikten genomfördes ändå då Friberg (2022) beskriver att metoden kan användas för att skapa en vägledning i omvårdnadsarbetet, vilket bedömdes vara relevant för arbetets syfte. Samtidigt innebar detta en utmaning vid tolkning och analys av de olika ansatsernas resultat. Valet av metod motiverades även av större förkunskaper om Fribergs metod vilket kan ha bidragit till en mer korrekt tillämpning. Under arbetets gång har även reflektion gjorts kring om en annan metod hade kunnat ge ett likvärdigt resultat. En allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2022) bedöms dock som relevant då den möjliggör jämförelser av likheter och skillnader, vilket bidrog till att identifiera återkommande mönster i kvinnornas erfarenheter av bemötande. I kvalitativa arbeten används termerna *trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet* och *överförbarhet* i diskussionsdelen (Friberg, 2022; Mårtensson & Fridlund, 2023). Följande diskussion kommer att utgå från dessa begrepp.

Trovärdighet i en litteraturöversikt handlar om i vilken grad resultatet speglar det som framkommer i de inkluderade studierna och att tolkningen av dessa görs på ett korrekt och systematiskt sätt (Friberg, 2022; Mårtensson & Fridlund, 2023). Samtliga inkluderade artiklar var vetenskapligt granskade via peer review eller kontrollerade via Ulrichsweb (Ulrichsweb, 2026) vilket ökar trovärdigheten i materialet (Östlundh, 2022). Alla artiklar i resultatet beskrev kvinnornas perspektiv av vårdpersonalens bemötande, vilket ligger i linje med arbetets syfte. En aspekt som har beaktats är skillnader i benämningar av vårdprofessioner mellan olika länder. I flera av de inkluderade studierna används begreppet ‘nurses’, vilket kan omfatta både sjuksköterskor och andra vårdprofessioner såsom undersköterskor. I föreliggande arbete har detta begrepp tolkats utifrån en svensk kontext som sjuksköterskor i den tidigare forskningen. I resultatartiklarna förekommer dock ett bredare vårdpersonalperspektiv, där olika yrkesgrupper kan vara representerade. Sammantaget bedöms dock både sjuksköterskans perspektiv i den tidigare forskningen och vårdpersonalens perspektiv i resultatet vara relevanta för allmänsjuksköterskans yrkesutövning, då de tillsammans bidrar till en helhetsförståelse av det kliniska arbetet och vårdsituationen. Alla artiklar som valdes ut var skrivna på engelska vilket underlättade analysen då författarna har goda språkkunskaper. I de fall där författarna kände sig osäkra i översättningen användes Google Översätt (Google Översätt, u.å) vilket kan ses som en styrka då det möjliggjorde en bättre förståelse för innehållet. Detta kan dock ha medfört en risk för feltolkningar, vilket påverkar trovärdigheten. Arbetet har dessutom kontinuerligt diskuterats med handledare och kurskamrater vilket enligt Mårtensson & Fridlund (2023) stärker trovärdigheten.

Pålitlighet handlar om i vilken grad arbetet kan genomföras på nytt med liknande resultat (Friberg, 2022; Mårtensson & Fridlund, 2023). Den stärks genom att sökprocessen dokumenterades (bilaga A), vilket enligt Hellberg och Karlsson (2023) möjliggör att processen kan följas och i viss mån upprepas. Valet att endast använda databaserna CINAHL Plus och PubMed motiverades av författarnas förkunskaper. Detta kan innebära en begränsning då relevanta studier i andra databaser kan ha exkluderats. Vidare användes inte Medical subject headings (MeSH) i PubMed och motsvarande CINAHL subject headings. Detta kan ha påverkat träffsäkerheten då relevanta synonymer därmed kan ha missats. Samtidigt stärks pålitligheten genom användningen av booleska operatorer, trunkering samt frassökning vilket enligt Hellberg & Karlsson, 2023; Polit & Beck, 2021; Östlundh, 2022 ökar

preciseringen i sökningarna. Enligt Hellberg och Karlsson (2023) kan litteratursökningar delas in i två delar: inledande ostrukturerade testsökningar och en mer strukturerad huvudsökning. De inledande testsökningarna genomfördes utan tidsbegränsning och gav många artiklar som var relevanta för arbetets syfte. När huvudsökningarna därefter genomfördes med avgränsningen att artiklarna skulle vara publicerade inom de senaste fem åren minskade antalet träffar som uppfyllde kriterierna, eftersom flera av de tidigare identifierade artiklarna var äldre än fem år och därför exkluderades. För att säkerställa ett tillräckligt underlag utökades tidsramen till tio år. Detta gjorde det möjligt att inkludera fler relevanta studier. Samtidigt innebar avgränsningen att studier äldre än tio år fortfarande exkluderades, även om vissa av dessa bedömdes vara relevanta, vilket kan ha påverkat arbetets pålitlighet. Ett arbetssätt som kan ha stärkt pålitligheten var att artiklarna först lästes individuellt och därefter gemensamt för att sedan diskutera, jämföra och sammanställa resultatet vilket minskar risken för subjektiva tolkningar. Förförståelsen har diskuterats kontinuerligt under arbetets gång, då arbetets fokus berör ett ämne som kan väcka starka känslor. Dagliga reflektioner och diskussioner kring detta har bidragit till en så transparent analysprocess som möjligt. Att vara medveten om sin förförståelse lyfts av Friberg (2022) som en viktig del för att undvika snedvridningar och felaktiga tolkningar i arbetet.

Bekräftelsebarhet handlar om i vilken grad det går att följa hur resultaten har vuxit fram ur det insamlade materialet, samt om tolkningarna kan spåras tillbaka till de inkluderade artiklarna (Friberg, 2022; Mårtensson & Fridlund, 2023). I detta arbete har bekräftelsebarheten stärkts genom att resultaten är tydligt refererade till de inkluderade studierna, vilket gör det möjligt för läsaren att följa hur tolkningarna har gjorts. För att ytterligare stärka detta har författarna återkommit till artiklarna under analysprocessen för att säkerställa att resultat inte bygger på egna antaganden, utan på det som faktiskt framkommit i materialet. Samtidigt kan bekräftelsebarheten ha påverkats av att materialet har behövt sammanfattas och tolkas, vilket innebär att vissa nyanser i originalstudierna kan ha gått förlorade. Detta kan påverka hur detaljerat läsaren kan följa varje enskild tolkning tillbaka till ursprungsartiklarna.

Överförbarhet handlar om i vilken grad resultaten kan tillämpas i andra kontexter och på andra grupper (Friberg, 2022; Mårtensson & Fridlund, 2023). Enstaka studier inkluderade deltagare som inte enbart identifierade sig som kvinnor. I deltagarantalet framgår en man samt en transkvinna. Detta har beaktats och bedöms att det kan ses som en begränsning i relation till arbetets syfte, då kvinnors erfarenheter är i fokus. Det gick dock inte att särskilja dessa deltagares erfarenheter från övriga deltagare, vilket kan ha påverkat resultatet. Samtidigt kan inkluderingen av dessa perspektiv bidra till ökad mångfald, samt göra att fler kan identifiera sig med resultatet och därmed stärka överförbarheten. Att majoriteten av studierna använde sig av kvalitativ ansats med få deltagare kan medföra att överförbarheten är låg. Samtidigt visade många studier liknande resultat samt att resultatet stärks av två kvantitativa studier gör att överförbarheten ökar. Att arbetet även inkluderade forskning från fem olika länder gör att resultatets överförbarhet kan styrkas. Det kan dock även ses som en svaghet eftersom skillnader i vårdsystem, lagstiftning och kulturella normer kan påverka hur resultaten tolkas. Att fem av artiklarna dessutom kom från USA kan även tolkas som en svaghet då de utgör cirka hälften av materialet finns risken att resultatet till hög grad speglat en amerikansk kontext.

6.3 Etikdiskussion

Detta arbete har genomförts som en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2022), vilket innebär att de etiska utmaningarna främst berör hantering av tidigare forskning snarare än direkt kontakt med studiedeltagare. Detta medför ett särskilt ansvar vid urval, tolkning och presentation av inkluderade studier, för att resultatet ska återges på ett rättvist och korrekt sätt. Detta kan kopplas till Vetenskapsrådet (2024), som beskriver att det är fritt att välja forskningsmetod och sammanställa resultat men att det ska utföras med ett ansvar att värna om god forskningssed.

Korrekt käll- och referenshantering enligt American Psychological Association (2026) har tillämpats för att säkerställa god forskningsetik och minska risken för oredlighet. Enligt Kjellström (2023) innebär oredlighet att plagiera, förvränga innehållet eller att inte ge erkännande till ursprungskällan i arbetet. Genom att konsekvent tillämpa korrekt referenshantering har en tydlig åtskillnad mellan insamlat material och egna resonemang eftersträvats. Trots detta kvarstår ett etiskt ansvar i arbetet att inte återge andras tolkningar som egna, vilket är särskilt viktigt att beakta vid omformulering av vetenskapliga texter.

De inkluderade studierna har granskats utifrån kvalitetskriterier för att säkerställa god vetenskaplig kvalitet. Samtliga studier innehöll etiska resonemang, det finns dock en begränsad insyn i hur dessa principer har tillämpats i praktiken. Detta innebär att arbetet delvis bygger på ett förtroende för andra forskares etiska ansvarstagande, vilket kan ses som en svaghet ur ett etiskt perspektiv och påverka resultatets tillförlitlighet. Ytterligare en etisk utmaning har varit språkhanteringen då samtliga artiklar är skrivna på engelska. Användning av översättningsverktyg har underlättat förståelsen, samtidigt som det kan ha påverkat tolkningen och återgivningen av resultaten. För att minska denna risk har översättningarna kontrollerats och resultaten satts i sitt sammanhang, även om feltolkningar inte helt kan uteslutas.

Förförståelsen utgör också en potentiell källa till bias (Friberg, 2022). Om litteratur läses tidigt i forskningsprocessen finns en risk att författarna söker sig till information som redan är bekant (Polit & Beck, 2021). Genom att kontinuerligt diskutera och reflektera med varandra har författarna strävat efter en transparens i arbetet. Trots en medveten strävan efter objektivitet kan tidigare erfarenheter och värderingar påverka både urval och tolkning av materialet. Fullständig objektivitet är svårt att uppnå i litteraturbaserad forskning, vilket gör reflektion kring den egna positionen till en viktig del av det etiska ansvaret. Det finns därmed en risk att vissa perspektiv omedvetet prioriteras framför andra.

Utifrån resultatet blir det även viktigt att beakta etiska aspekter kopplade till hur kvinnor som utsatts för våld i nära relation beskrivs. Detta stärks av Kjellström (2023) som beskriver att om deltagarna i studien är utsatta eller sårbara blir etiska övervägande särskilt relevanta för att värna om deltagarnas integritet och värdighet. Resultatet innehåller både positiva och negativa erfarenheter av bemötande, vilket kan påverka hur bilden av hälso- och sjukvården framställs. Detta kan i sin tur påverka tilliten till vårdpersonalen. Samtidigt var det etiskt viktigt att synliggöra dessa erfarenheter, då de tillsammans bidrar till ökad förståelse och utveckling av vården. Arbetets nytta bedöms därför överväga dess risker, eftersom ökad kunskap om bemötandets betydelse kan stärka vårdpersonalens förmåga att möta kvinnor

som utsatts för våld i nära relation på ett respektfullt och stödjande sätt. Detta stöds även av Kjellström (2023) som beskriver att forskningen ska leda till nytta för samhället, mänskligheten eller en profession.

7 SLUTSATS

Bemötande från vårdpersonal har en avgörande betydelse för kvinnors trygghet, tillit och benägenhet att berätta om våld i nära relation inom hälso- och sjukvården. Ett vårdande och personcentrerat förhållningssätt framstår därmed som en förutsättning för att våld i nära relation ska kunna synliggöras och för att kvinnor ska få tillgång till adekvat stöd och hjälp. Organisatoriska förutsättningar såsom tidsbrist, hög arbetsbelastning och brist på enskilda samtalsutrymmen påverkar möjligheterna att ge ett tryggt och lyhört bemötande. Detta visar att ansvaret för ett gott bemötande inte enbart kan förstås som en individuell kompetens hos vårdpersonal, utan även som en strukturell och organisatorisk fråga inom hälso- och sjukvården. När kvinnor inte blir lyssnade på, trodda eller bekräftade riskerar detta att bidra till ökat vårdlidande och minskad tillit till hälso- och sjukvården. Ett vårdande bemötande är därför viktigt för att minska lidande och stärka vårdrelationen mellan vårdpersonal och kvinnor som utsatts för våld i nära relation.

7.1 Kliniska implikationer

Det finns ett tydligt behov av att utveckla både kunskap och organisatoriska förutsättningar inom hälso- och sjukvården. Vårdpersonal behöver ökad utbildning inom våld i nära relation, med fokus på kommunikation, bemötande och identifiering av utsatthet. Detta kan bidra till ökad trygghet i yrkesrollen och förbättrade vårdmöten. Vidare behöver vårdorganisationer skapa bättre förutsättningar för ett personcentrerat bemötande. Det innefattar tillgång till enskilda samtalsutrymmen, tydliga riktlinjer och strukturer samt möjligheter till kontinuitet i vården. Små handlingar i vårdmötet, såsom närvaro och bekräftelse har visat sig vara av betydelse för kvinnors erfarenheter av bemötandet av vårdpersonal, vilket innebär att förbättringar inte enbart kräver ökade resurser utan även ett medvetet förhållningssätt i det dagliga arbetet. Genom att integrera kvinnors erfarenheter i utvecklingen av vårdpraktiken kan vården i högre grad anpassas efter deras behov, vilket kan bidra till att minska vårdlidande och stärka tilliten till hälso- och sjukvården. Detta förutsätter att kunskap om våld i nära relation inte ses som något separat, utan som en naturlig del av det kliniska arbetet där reflektion och kontinuerlig kompetensutveckling blir en del av vardagen i hälso- och sjukvården.

7.2 Förslag på framtida forskning

Det finns behov av vidare forskning kring hur utbildningsinsatser inom våld i nära relation påverkar bemötandet från vårdpersonal i praktiken. Det är viktigt att undersöka om ökad kunskap leder till förbättrade vårdmöten och ökad identifiering av våld i nära relation. Vidare behövs forskning som fokuserar på organisatoriska faktorer, såsom tidsbrist och vårdmiljö, för att förstå hur dessa påverkar möjligheten att ge ett gott bemötande. Detta är viktigt för att kunna utveckla vårdens struktur och skapa bättre förutsättningar för personcentrerad vård. Ytterligare forskning skulle även kunna jämföra olika vårdkontexter, exempelvis akutsjukvård och primärvård, för att undersöka om bemötandet och möjligheten att identifiera våld i nära relation skiljer sig beroende på vårdmiljö. Det finns även behov av fler studier som belyser variationer i erfarenheter, exempelvis utifrån kulturell bakgrund, för att öka förståelsen för hur olika livsvillkor kan påverka erfarenheter av bemötandet inom hälso- och sjukvården vid våld i nära relation och därigenom möjliggöra ett mer jämlikt vårdande.

Slutligen behövs longitudinella studier som undersöker de långsiktiga konsekvenserna av bemötandet, exempelvis hur det påverkar kvinnors fortsatta vårdsökande och återhämtning. Detta är viktigt för att förstå bemötandets betydelse över tid och för att kunna utveckla hållbara vårdinsatser.

REFERENSLISTA

*Artikeln ingår i resultatdelen

Alshammari, K. F., McGarry, J., & Higginbottom, G. M. A. (2018). Nurse education and understanding related to domestic violence and abuse against women: An integrative review of the literature. *Nursing Open, 5*(3), 237–253. https://doi.org/10.1002/nop2.133

American Psychological Association. (2026). *APA style*. https://apastyle.apa.org/

*Aregger Lundh, A., Tannlund, C., & Kristensson Ekwall, A. (2025). *Experiences of unplanned healthcare encounters from victims of intimate partner violence in Sweden. BMJ Public Health, 3*(1), e002041. https://doi.org/10.1136/bmjph-2024-002041

Aregger Lundh, A., Tannlund, C., & Ekwall, A. (2023). *More support, knowledge and awareness are needed to prepare emergency department nurses to approach potential intimate partner violence victims. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 37*(2), 397–405. https://doi.org/10.1111/scs.13123

Aydin, E., & Karaçar, Y. (2025). Professional self-efficacy and readiness to encounter individuals exposed to partner abuse in nurses: A cross-sectional study. *Journal of Advanced Nursing, 82*(4), 3007–3018. https://doi.org/10.1111/jan.70001

Bentling, S. (2010). Vårdpedagogik – en introduktion. I S. Bentling & B. Jonsson (Red.), *Vårdpedagogiska utmaningar* (s. 12–48). Liber.

Billhult, A., & Henricson, M. (2023). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), *Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap* (3:e uppl., s. 115–127). Studentlitteratur.

Briones-Vozmediano, E., Otero-García, L., Gea-Sánchez, M., De Fuentes, S., García-Quinto, M., Vives-Cases, C., & Maquibar, A. (2022). A qualitative content analysis of nurses' perceptions about readiness to manage intimate partner violence. *Journal of Advanced Nursing, 78*(5), 1448–1460. https://doi.org/10.1111/jan.15119

*Dichter, M. E., Ogden, S. N., Tuepker, A., Iverson, K. M., & True, G. (2021). *Survivors' input on health care-connected services for intimate partner violence. Journal of Women's Health, 30*(12), 1744–1750. https://doi.org/10.1089/jwh.2020.8585

Duarte, J., & Pinto-Gouveia, J. (2017). Understanding management and support for domestic violence and abuse within emergency departments: A systematic literature review from 2000–2015. *Journal of Clinical Nursing, 26*(23–24), 4013–4027. https://doi.org/10.1111/jocn.13849

Duchesne, E., Nathoo, A., Walker, M., & Bartels, S. A. (2023). Patient and provider emergency care experiences related to intimate partner violence: A systematic review of the existing evidence. *Trauma, Violence, & Abuse, 24*(5), 2901–2921. https://doi.org/10.1177/15248380221118962

Ekebergh, M. (2022a). Hälsa – ett livsvärldsperspektiv. I M. Arman, K. Dahlberg & M. Ekebergh (Red.), *Teoretiska grunder för vårdande* (2. uppl., s. 30–43). Liber.

Ekebergh, M. (2022b). Vårdande möten. I M. Arman, K. Dahlberg & M. Ekebergh (Red.), *Teoretiska grunder för vårdande* (2. uppl., s. 138–145). Liber.

Engström, Å., & Juuso, P. (2023). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), *Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap* (3:e uppl., s. 151–164). Studentlitteratur.

Eriksson, K. (2018). *Vårdvetenskap: Vetenskapen om vårdandet – Om det tidlösa i tiden*. Liber.

Etikprövningslagen (SFS 2003:460). *Lag om etikprövning av forskning som avser människor*. Svensk författningssamling. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460

Friberg, F. (2022). Att göra en litteraturöversikt av kvantitativ och kvalitativ forskning. I F. Friberg (red.), *Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten* (4:e uppl., s. 185–198). Studentlitteratur.

Gandhi, S., Poreddi, V., Nikhil, R. S., Palaniappan, M., & Math, S. B. (2018). Indian novice nurses' perceptions of their role in caring for women who have experienced intimate partner violence. *British Journal of Nursing, 27*(10), 559–564. https://doi.org/10.12968/bjon.2018.27.10.559

Google. (2026). *Google Översätt*. Hämtad 23 april 2026, från https://translate.google.com

Hellberg, S., & Karlsson, E. K. (2023). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), *Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap* (3:e uppl., s. 85–102). Studentlitteratur.

Henricson, M. (2023). Forskningsprocessen. I M. Henricson (Red.), *Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap* (3:e uppl., s. 45–60). Studentlitteratur.

*Heron, R. L., Eisma, M. C., & Browne, K. (2022). Barriers and facilitators of disclosing domestic violence to the UK health service. *Journal of Family Violence, 37*(4), 533–543. https://doi.org/10.1007/s10896-020-00236-3

*Hollingdrake, O., Saadi, N., Alban Cruz, A., & Currie, J. (2023). Qualitative study of the perspectives of women with lived experience of domestic and family violence on accessing healthcare. *Journal of Advanced Nursing, 79*(4), 1353–1366. https://doi.org/10.1111/jan.15316

*Hooker, L., Versteegh, L., Lindgren, H., & Taft, A. (2020). Differences in help-seeking behaviors and perceived helpfulness of services between abused and non-abused women: A cross-sectional survey of Australian postpartum women. Health & Social Care in the Community, 28(3), 958–968. https://doi.org/10.1111/hsc.12927

Kjellström, S. (2023). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), *Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap* (3:e uppl., s. 61–84). Studentlitteratur.

Li, Q., Zeng, J., Zhao, B., Perrin, N., Wenzel, J., Liu, F., Pang, D., Liu, H., Hu, X., Li, X., Wang, Y., Davidson, P. M., Shi, L., & Campbell, J. C. (2024). *Nurses' preparedness, opinions, barriers, and facilitators in responding to intimate partner violence: A mixed-methods study*. Journal of Nursing Scholarship, 56(1), 174–190. https://doi.org/10.1111/jnu.12929

*McGarry, J., & Hinsliff-Smith, K. (2021). Silent voices: Exploring narratives of women's experiences of healthcare encounters following domestic violence and abuse. *Journal of Medical Humanities, 42*(2), 245–252. https://doi.org/10.1007/s10912-020-09621-x

*Moore, K. M., Wesp, L. M., Luebke, J. M., & Kako, P. M. (2025). *Black women's experiences accessing health care and law enforcement after intimate partner violence: A qualitative pilot study. Western Journal of Nursing Research, 47*(12), 1203–1213. https://doi.org/10.1177/01939459251377945

Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2023) Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M. Henricson (Red.), *Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap* (3:e uppl., s. 473–489). Studentlitteratur.

*Olive, P. (2017). *First contact: Acute stress reactions and experiences of emergency department consultations following an incident of intimate partner violence. Journal of Clinical Nursing, 26*(15-16), 2317–2327. https://doi.org/10.1111/jocn.13311

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Wolters Kluwer.

Rahmqvist, J., Benzein, E., & Erlingsson, C. (2019). Challenges of caring for victims of violence and their family members in the emergency department. *International Emergency Nursing, 42*, 2–6. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2018.10.007

*Reeves, E. A., & Humphreys, J. C. (2018). Describing the healthcare experiences and strategies of women survivors of violence. *Journal of Clinical Nursing, 27*(5–6), 1170–1182. https://doi.org/10.1111/jocn.14152

Renner, L. M., Wang, Q., Logeais, M. E., & Clark, C. J. (2019). Health care providers' readiness to identify and respond to intimate partner violence. *Journal of Interpersonal Violence, 36*(19–20), 9507–9534. https://doi.org/10.1177/0886260519867705

Ruiz-Fernández, M. D., Ortiz-Amo, R., Alcaraz-Córdoba, A., Rodríguez-Bonilla, H. A., Hernández-Padilla, J. M., Fernández-Medina, I. M., & Ventura-Miranda, M. I. (2022). Attention given to victims of gender violence from the perspective of nurses: A qualitative study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(19), 12925. https://doi.org/10.3390/ijerph191912925

Patientlag (SFS 2014:821). Socialdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821

Segersten, K. (2022). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F. Friberg (Red.), *Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten* (4:e uppl., s. 139–145). Studentlitteratur.

Socialstyrelsen. (2024). *Hälso- och sjukvårdens roll*. https://forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se/samverkan/halso--och-sjukvardens-roll/

Socialstyrelsen. (2025). *Hälso- och sjukvårdspersonal*. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/vem-far-gora-vad/styrning-och-arbetsfordelning/halso-och-sjukvardspersonal/

Socialstyrelsen. (2023). *Våld i nära relationer – Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården*. Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker--juridisk-handbok/2023-6-8592.pdf

Sundborg, E. (2024). *Vårdmöten vid våld i nära relationer*. Liber.

Svensk sjuksköterskeförening. (2024). *Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska*. https://beta.swenurse.se/publikationer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska

*Swailes, A. L., Lehman, E. B., & McCall-Hosenfeld, J. S. (2017). *Intimate partner violence discussions in the healthcare setting: A cross-sectional study*. Preventive Medicine Reports, 8, 215–220. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2017.10.017

Ternestedt, B.-M., & Norberg, A. (2019). Livscykel och identitet. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), *Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt* (3:e uppl., s. 67–95). Studentlitteratur.

Ulrichsweb. (2026). *Ulrichsweb global serials directory*. ProQuest. https://www.ulrichsweb.com

Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed*. Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html

*Wallin Lundell, I., Eulau, L., Bjarneby, F., & Westerbotn, M. (2017). *Women's experience with healthcare professionals after suffering from gender-based violence: An interview study*. *Journal of Clinical Nursing, 27*(5-6), 949–957. https://doi.org/10.1111/jocn.14046

*Williams, J. R., Gonzalez-Guarda, R. M., Halstead, V., Martinez, J., & Joseph, L. (2020). *Disclosing gender-based violence during health care visits: A patient-centered approach*. *Journal of Interpersonal Violence, 35*(23–24), 5552–5573. https://doi.org/10.1177/0886260517720733

Willman, A. (2019). Hälsa och välbefinnande. I A.-K. Edberg & H. Wijk (Red.), *Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa* (3:e uppl., s. 33–48). Studentlitteratur.

Östlundh, L. (2022). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), *Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten* (4:e uppl., s. 79–110). Studentlitteratur.

BILAGA A; SÖKMATRIS

Databas Datum för sökning	Sökord	Urval	Antal träffar	Antal lästa abstract	Antal lästa artiklar (fulltext)	Valda artiklar
CINAHL plus 2026-04-04	”intimate partner violence” OR ”Domestic violence” OR IPV AND experience* AND healthcare* NOT systematic review or meta analysis AND patient NOT children	Peer reviewed English 2016-2026	87	7	1	Woman’s experience with healthcare professionals after suffering from gender-based violence
CINAHL plus 2026-04-07	domestic violence AND experience* AND healthcare NOT children or adolescents or youth or child or teenager NOT systematic review or meta analysis	Peer reviewed English 2016-2026	195	40	3	Qualitative study of the perspectives of women with lived experience of domestic and family violence on accessing healthcare Black Women’s Experiences Accessing Health Care and Law Enforcement After Intimate Partner Violence: A Qualitative Pilot Study Barriers and Facilitators of Disclosing Domestic Violence to the UK Health Service
CINAHL plus 2026-04-07	"intimate partner violence" AND experience* AND "emergency departments" NOT children or	Peer reviewed English 2016-2026	16	11	1	First contact: acute stress reactions and experiences of emergency department consultations following an incident of intimate partner violence

	youth or child or teenager					
PubMed 2026-04-07	(Experiences) AND (healthcare) AND (victim of intimate partner violence)	English 2016–2026	149	35	3	Disclosing Gender-Based Violence During Health Care Visits: A Patient-Centered Approach Experiences of unplanned healthcare encounters from victims of intimate partner violence in Sweden Survivors' Input on Health Care-Connected Services for Intimate Partner Violence
PubMed 2026-04-15	(domestic violence) AND (abuse) AND (women) AND (experiences) AND (health care professionals) NOT (male)	English 2016–2026	54	12	2	Describing the healthcare experiences and strategies of women survivors of violence Silent Voices: Exploring Narratives of Women's Experiences of Health Care Professional Responses to Domestic Violence and Abuse
PubMed 2026-04-21	(intimate partner violence) AND (domestic violence) AND (healthcare) AND (screening) NOT (children) NOT (male)	English 2016–2026	96	40	1	Intimate partner violence discussions in the healthcare setting: A cross-sectional study
PubMed 2026-05-08	(intimate partner violence) AND (abused) AND (health care) AND (women) AND	English 2016–2026	44	28	1	Differences in help-seeking behaviours and perceivedhelpfulness of services between abused and non-abusedwomen: A cross-sectional survey of Australian postpartumwomen

	(help-seeking) NOT (male)					

BILAGA B; KVALITETSGRANSKNING

Artiklarna har kvalitetsgranskats enl. dessa frågor inspirerade av Friberg (2022) för att kontrollera deras vetenskapliga kvalitet.

1 = Uppfyllt

0 = Ej uppfyllt

Författare	**Fråga**									**Poäng**
	1.Finns det ett tydligt problem formulerat?	2. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven?	3. Är syftet tydligt formulerat?	4. Finns det en metod beskriven?	5. Är urvalet av deltagare tydligt beskrivet?	6. Har dataanalyserats med adekvata metoder?	7. Är resultatet tydligt beskrivet?	8. Finns det en metoddiskussion?	9. Förs det några etiska resonemang?	
Aregger Lundh et al.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8/9
Dichter et al.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8/9
Heron et al.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8/9
Hollingdrake et al.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9/9
Hooker et al.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8/9
McGarry & Hinsliff-Smith	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8/9

Moore et al.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8/9
Olive, P.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9/9
Reeves & Humphreys	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8/9
Swailes et al.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8/9
Wallin Lundell et al.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8/9
Williams et al.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8/9

BILAGA C; ARTIKELMATRIS

Information	Titel	Syfte	Metod	Resultat	Kvalitets poäng
Författare: Aregger Lundh, A., Tannlund, C., & Kristensson Ekwall, A. **Årtal:** 2025 **Tidskrift:** BMJ Public health **Land:** Sverige	**Titel:** Experiences of unplanned healthcare encounters from victims of intimate partner violence in Sweden	**Syfte:** Investigate experiences and expectations in the care of adults who had experienced IPV (Intimate partner violence)	**Ansats:** Kvalitativ **Datainsamling:** Semistrukturerade intervjuer **Dataanalys:** Kvalitativ innehållsanalys **Deltagarnas ålder:** 25–53 år **Antal deltagare**: 11	**Resultat:** Erfarenheter av bemötande från vårdpersonalen präglades av en balans mellan att bli sedd och att bli förbisedd. Empatiskt, närvarande och icke-dömande bemötande främjade tillit och möjligheten att berätta om våld, medan bristande bemötande, uteblivna frågor och fokus på enbart fysiska symtom bidrog till att våld i nära relation förblev dolt.	8/9 poäng
Författare: Dichter, M. E., Ogden, S. N., Tuepker, A., Iverson, K. M., & True, G **Årtal:** 2021 **Tidskrift:** Journal for women's health **Land:**USA	**Titel:** Survivors' Input on Health Care-Connected Services for Intimate Partner Violence	**Syfte:** To understand IPV survivors' experiences with and perspectives on health care-connected IPV services	**Ansats:** Kvalitativ **Datainsamling:** Semistrukturerade intervjuer **Dataanalys:** Kvalitativ innehållsanalys **Deltagarnas ålder:** 22-64år **Antal deltagare:** 68	**Resultat:** Vårdpersonalens bemötande hade en avgörande betydelse för kvinnornas möjligheter att få stöd vid våld i nära relation. Erfarenheterna visade att information, aktiv vägledning och ett lyhört och tryggt bemötande kunde underlätta hjälpsökande, medan brist på information, uppföljning och praktiskt stöd riskerade att hindra kvinnorna från att söka eller ta emot hjälp. Bemötandet behövde därför präglas av tillit, respekt för självbestämmande samt hänsyn till kvinnornas behov av säkerhet och integritet.	8/9 poäng
Författare: Heron, R. L., Eisma, M. C., & Browne, K.	**Titel:** Barriers and Facilitators of Disclosing Domestic	**Syfte:** To explore victims' perceptions and experiences of disclosing to health care services and to identify barriers and	**Ansats:** Kvalitativ	**Resultat:** Kvinnornas erfarenheter av bemötande i vården vid våld i nära relation påverkades av emotionella, organisatoriska och relationella faktorer.	8/9 poäng

Årtal: 2022 **Tidskrift:** Journal of Family Violence **Land:** Storbritannien	Violence to the UK Health Service	facilitators of disclosure within an ethnically diverse UK sample	**Datainsamling**: Semistrukturerade intervjuer **Dataanalys:** Kvalitativ innehållsanalys **Deltagarnas ålder:** 21 till 49år **Antal deltagare**: 29	Kvinnorna beskrev att de sällan blev direkt tillfrågade om utsatthet för våld i nära relation. De erfor även hinder i vårdmiljön som försvårade möjligheten att berätta, exempelvis att partnern var närvarande under vårdmötet och att de därmed inte kunde tala enskilt. Vidare framkom erfarenheter av tidsbrist inom hälso- och sjukvården, där kvinnorna erfor att vårdpersonalen inte hade möjlighet att skapa trygghet och tillit. Samtidigt beskrevs empatiskt bemötande, lyssnande och tillit till vårdpersonalen som viktiga faktorer som underlättade att berätta om utsatthet för våld i nära relation.	
Författare: Hollingdrake, O., Saadi, N., Alban Cruz, A., & Currie, J. **Årtal:** 2023 **Tidskift:** Journal of advanced nursing **Land:** Australien	**Titel:** Qualitative study of the perspectives of women with lived experience of domestic and family violence on accessing healthcare	**Syfte:** To explore the perceptions of women with lived experience of domestic and family violence on accessing healthcare and to identify how nurses can facilitate and support women experiencing domestic and family violence to receive the care they need	**Ansats:** Kvalitativ **Datainsamling:** Fokusgrupp med 8 öppna frågor **Dataanalys:** Tematisk analys **Deltagarnas ålder:** över 18år **Antal deltagare:** 4	**Resultat:** Kvinnorna beskrev erfarenheter av det första bemötandet inom hälso- och sjukvården, där både positiva och negativa erfarenheter framkom. Bemötandet erfors som avgörande för om en fortsatt vårdkontakt etablerades. Vidare framhölls betydelsen av att vårdpersonalen, skapade trygghet och tillit i mötet för att möjliggöra att kvinnorna vågade berätta att de utsatts för våld i nära relation. Kvinnorna beskrev även erfarenheter av bristande kunskap hos vårdpersonalen kring våld i nära relation, vilket påverkade bemötandet negativt.	9/9 poäng
Författare: Hooker, L., Versteegh, L.,	**Titel:** Differences in help-seeking behaviours and perceivedhelpfulness of services between	**Syfte:** The aims of this study were to: identify help-seeking behaviours and perceived helpfulness of Australian healthcare	**Ansats:** Kvantitativ	**Resultat:** Kvinnorna som utsatts för våld i nära relation sökte oftare hjälp inom hälso- och sjukvården, bland annat på akutmottagningar och via	8/9 poäng

Lindgren, H., & Taft, A. **Årtal:** 2019 **Tidskrift:** Health & Social Care in the Community **Land:** Australien	abused and non-abusedwomen: A cross-sectional survey of Australian postpartumwomen	services used by postpartum women and examine possible differences in help-seeking behaviour and perceived helpfulness between women exposed to IPV and women not exposed to IPV	**Datainsamling:** Tvärsnittsstudie, enkät **Dataanalys:** Kvantitativ deskriptiv analys **Deltagarnas ålder:** Ålder ej specificerad **Antal deltagare:** 2621	sjuksköterskeledda hembesöksprogram. Kvinnorna erfor bemötandet och hjälpen från vården som mindre hjälpsam jämfört med kvinnorna som inte utsatts för våld i nära relation. Studien betonade vikten av att vårdpersonalen identifierade våld i nära relation samt erbjöd ett tryggt, stödjande och lyhört bemötande.	
Författare: McGarry, J., & Hinsliff-Smith, K. **Årtal:** 2020 **Tidskrift:** Journal of Medical Humanities **Land:** Storbritannien	**Titel:** Silent Voices: Exploring Narratives of Women's Experiences of Health Care Professional Responses to Domestic Violence and Abuse	**Syfte:** To explore women's experiences of healthcare encounters following domestic violence and abuse (DVA), presented as personal narratives	**Ansats:** Kvalitativ **Datainsamling:** Fokusgrupp med kvinnor som erfarenhet av DVA; muntliga berättelser och diskussioner (fältanteckningar användes, ingen ljudinspelning). **Dataanalys:** Narrativ analys **Deltagarnas ålder:** Ålder ej specificerad **Antal deltagare:** 6	**Resultat:** Kvinnorna beskrev erfarenheter av mötet med vårdpersonalen, där rädsla, skam och skuld ofta var framträdande och försvårade berättande om våld i nära relation. De erfor oro för konsekvenser såsom att socialtjänst kopplades in eller att barn togs ifrån dem. Erfarenheter av vårdmiljön beskrevs som stressiga och otrygga, vilket ytterligare hindrade öppenheten. Bemötandet varierade mellan empatiskt stöd och bristande identifiering av våld i nära relation samt erfarenheter av skuldbeläggning. Kvinnorna erfor även att de upplevdes som en belastning vid upprepade vårdbesök och att stödet ofta var otillräckligt även när våld i nära relation uppmärksammades.	8/9 poäng
Författare: Moore, K. M., Wesp, L. M., Luebke, J. M., & Kako, P. M.	**Titel:** Black Women's Experiences Accessing Health Care and Law Enforcement After Intimate Partner	**Syfte:** To explore African American women's experiences with IPV and navigation of health care	**Ansats:** Kvalitativ **Datainsamling:** Semistrukturerade intervjuer	**Resultat:** Kvinnorna beskrev erfarenheter av brister i vårdpersonalens bemötande. Detta innefattade otillräcklig identifiering av våld i nära realation, känslor av att inte bli trodda, otrygga	8/9 Poäng

Årtal: 2025 **Tidskrift:** Western Journal of Nursing Research **Land:** USA	Violence: A Qualitative Pilot Study	and law enforcement after experiences of violence	**Dataanalys:** Tematisk analys **Deltagarnas ålder:** 40 till 52 år **Antal deltagare**: 5	vårdsituationer samt brist på stöd och uppföljning efter vårdkontakt. Dessa erfarenheter påverkade kvinnornas tillit till vården och deras möjlighet att få adekvat hjälp och stöd.	
Författare: Olive, P. **Årtal:** 2017 **Tidskrift:** Journal of Clinical Nursing **Land:** Storbritannien	**Titel:** First contact: Acute stress reactions and experiences of emergency department consultations following an incident of intimate partner violence	**Syfte:** To explore women's emotional and affective responses following an incident of intimate partner violence experienced during emergency department attendances	**Ansats:** Kvalitativ **Datainsamling:** Semistrukturerade intervjuer **Dataanalys:** Tematisk analys **Deltagarnas ålder:** Vuxna (ålder ej specificerad) **Antal deltagare**: 6	**Resultat**: Erfarenheter av bemötandet i akutsjukvården varierade mellan att vara stödjande och otillräckligt. Positiva erfarenheter beskrevs som ett empatiskt och lyhört bemötande där kvinnorna erfor sig sedda och bekräftade. Negativa erfarenheter präglades av brist på emotionellt stöd samt svårigheter att bli förstådd i sitt akuta tillstånd. Kvinnorna uttryckte ett behov av ökad närvaro, trygghet och förståelse i mötet med vårdpersonalen.	9/9 poäng
Författare: Reeves, E. A., & Humphreys, J. C. **Årtal:** 2018 **Tidskrift**: Journal of Clinical Nursing **Land:** USA	**Titel:** Describing the healthcare experiences and strategies of women survivors of violence	**Syfte:** To develop knowledge on women survivors' healthcare experiences and strategies	**Ansats:** Kvalitativ **Datainsamling**: Semistruktuerade intervjuer **Dataanalys:** Kvalitativ innehållsanalys **Deltagarnas ålder**: 22-63år **Antal deltagare:** 14	**Resultat:** Erfarenheter av bemötande präglades av tidigare trauma där gynekologiska undersökningar, beröring av vissa kroppsdelar samt vårdpersonalens kroppsspråk och gester kunde utlösa starka känslomässiga reaktioner och traumatiska minnen. Detta bidrog till att vårdmötet erfors som otryggt och oförutsägbart, samt som en fortsättning på tidigare trauma snarare än en neutral vårdsituation. Bristande kommunikation och otydlighet från vårdpersonalen förstärkte erfarenheter av kontrollförlust och utsatthet i vårdsituationen.	8/9 poäng

Författare: Swailes, A. L., Lehman, E. B., & McAll-Hosenfeld, J. S. **Årtal:** 2017 **Tidsskrift:** Preventive Medicine Reports **Land:** USA	**Titel:** Intimate partner violence discussions in the healthcare setting: A cross-sectional study	**Syfte:** To examine outcomes of IPV screening, including use of guideline-concordant discussion topics and interventions, as well as patient perception of the encounters	**Ansats:** Kvantitativ **Datainsamling:** Tvärsnittsstudie, enkät **Dataanalys:** Kvantitativ deskriptiv analys **Deltagarnas ålder:** 18-64år **Antal deltagare:** 253	**Resultat:** 39 % av kvinnorna hade blivit tillfrågade om våld i nära relation inom hälso- och sjukvården. Bland dessa varierade bemötandet i innehåll och kvalitet; 30 % av samtalen saknade riktlinjeanpassade diskussionspunkter och 28 % ledde inte till några relevanta insatser. Vanliga inslag i samtalen var emotionell/psykisk hälsa, oro och säkerhetsbedömning. Trots brister i samtalen visade studien att majoriteten av kvinnorna hade positiva erfarenheter, där cirka 57 % var mycket eller extremt nöjda och 52 % mycket eller extremt bekväma med samtalet.	8/9 poäng
Författare: Wallin Lundell, I., Eulau, L., Bjarneby, F., & Westerbotn, M. **Årtal:**2017 **Tidsskrift:** Journal of Clinical Nursing **Land:** Mexico	**Titel:** Woman's experience with healthcare professionals after suffering from gender-based violence	**Syfte:** To describe how women in Mexico whohave suffered from gender-based violence experience their encounters with health care proffessionals	**Ansats:** Kvalitativ **Datainsamling**: Semistrukturerade intervjuer **Dataanalys:** Induktiv innehållsanalys **Deltagarnas ålder:** 21 till 49 år **Antal deltagare**: 7	**Resultat:** Kvinnorna som utsatts för våld i nära relation hade erfarenheter av att bemötandet från vårdpersonalen kunde vara skuldbeläggande, särskilt när deras handlingar ifrågasattes eller när personalen gav dömande blickar eller hade ett nedlåtande tonfall. De hade också erfarenheter av att inte bli tagna på allvar när vårdpersonalen var distraherad eller stressad. Bristande trygghet i bemötandet kunde även hindra dem från att berätta om våld i nära relation eller söka stöd.	8/9 poäng
Författare: Williams, J. R., Gonzalez Guarda, R. M., Halstead, V., Martinez, J., & Joseph, L.	**Titel:** Disclosing Gender-Based Violence During Health Care Visits: A Patient-Centered Approach	**Syfte:** To better understand victims' perspectives regarding decisions to disclose gender-based violence, namely, intimate partner violence (IPV) and human	**Ansats:** Kvalitativ **Datainsamling:** Semistrukturerade intervjuer	**Resultat:** Kvinnorna beskrev erfarenheter av att ett empatiskt och respektfullt bemötande skapade trygghet och underlättade möjligheten att berätta om våld i nära relation. Samtidigt framkom erfarenheter av att tidsbrist,	8/9 poäng

Årtal: 2020 **Tidskrift:** Journal of Interpersonal Violence **Land:** USA		trafficking, to health care providers and what outcomes matter to them when discussing these issues with their provider	**Dataanalys:** Kvalitativ innehållsanalys **Deltagarnas ålder:** 18 till 43 år **Antal deltagare:** 25	bristande engagemang och rädsla för negativa konsekvenser försvårade detta. Erfarenheter av förtroende och konfidentialitet, samt behov av att bli förstådda och få stöd, framträdde som viktiga.	



Box 883, 721 23 Västerås **Tfn:** 021-10 13 00
Box 325, 631 05 Eskilstuna **Tfn:** 016-15 36 00
E-post: info@mdh.se **Webb:** www.mdu.se